

Proyecto Final.

Gallardo Valdez Brayan Alexis Granados Rovira José Pablo
Lozano León Diego Márquez Corona Danna Lizette
Paredes González Emiliano Sebastián Tapia Anrubio Irving Axel

29 de Mayo de 2026



Índice

1. Introducción	4
2. Análisis de requerimientos	4
3. Consideraciones de diseño	4
3.1. Sucursal y clínica	5
3.2. Personal y especialización	5
3.3. Medicamentos que preparan los farmacéuticos	6
3.4. Insumos	6
3.5. Clientes y tipos de cliente	6
3.6. Regla de descuentos	7
3.7. Consultas médicas	7
3.8. Recetas médicas	7
3.9. Medicamentos	8
3.10. Proveedores	8
3.11. Tickets	9
3.12. Control de inventario	9
3.13. Compra en línea	10
3.14. Decisiones generales de integridad	10
4. Modelo Entidad–Relación	10
5. Modelo Relacional	11
6. Dependencias funcionales	12
7. Implementación física en PostgreSQL	22
7.1. Estrategia de creación y limpieza del esquema	22
7.2. Selección de tipos de dato	22
7.3. Integridad de entidad: llaves primarias	22
7.4. Integridad de dominio: NOT NULL, CHECK, UNIQUE y DEFAULT	23
7.5. Integridad referencial: llaves foráneas y acciones referenciales	24
7.6. Documentación del esquema y orden de carga	24
8. Poblamiento de la base de datos	24
9. Procedimientos, funciones y disparadores	26
9.1. Funciones (archivo <code>Funciones.sql</code>)	26
9.2. Procedimientos almacenados (archivo <code>SP.sql</code>)	27
9.3. Archivo de triggers	27
9.4. Importancia de los triggers	28
9.5. Control del stock de medicamentos	28
9.6. Cálculo de descuentos	29
9.7. Cálculo del precio bruto y precio neto	30
9.8. Eventos que detectan los triggers	30
9.9. Relación con la integridad de los datos	31
9.10. Alcance del archivo	31

10.Consultas	32
10.1. Consulta xiv — Distribución de sucursales por estado	32
10.2. Consulta xv — Sucursales con clínica y capacidad médica	32
10.3. Consulta xvi — Cantidad de empleados por sucursal	33
10.4. Consulta xvii — Salarios promedio por categoría de empleado	34
10.5. Consulta xviii — Farmacéuticos y preparación de medicamentos especiales	34
10.6. Consulta xix — Métodos de pago utilizados por clientes	35
10.7. Consulta xx — Tickets con descuentos o promociones	36
10.8. Consulta xxi — Número de consultas médicas realizadas	36
10.9. Consulta xxii — Médicos activos y productividad	37
10.10Consulta xxiii — Recetas relacionadas con alergias	38
10.11Consulta xxiv — Stock e inventario por sucursal	39
10.12Consulta xxv — Medicamentos próximos a caducar	40
10.13Consulta xxvi — Proveedores de medicamentos e insumos	41
10.14Consulta xxvii — Ventas presenciales vs ventas en línea	41
10.15Consulta xxviii — Comparación entre ingresos médicos y ventas de medicamentos	42
11.Conclusión	43

1. Introducción

El proyecto se basa en el caso de uso *Una farmacia de otro mundo*, donde se busca diseñar una base de datos para administrar mejor la información de una cadena de farmacias. La idea principal es dejar de depender de registros físicos, hojas de cálculo o información separada, y pasar a un sistema más organizado que permita manejar sucursales, clientes, personal, proveedores, medicamentos, insumos, consultas médicas, recetas y tickets.

En nuestro caso, el proyecto fue trabajado a partir de las prácticas realizadas durante el semestre. Primero se identificaron las entidades principales del problema y después se fueron corrigiendo los diagramas y scripts conforme avanzaban las entregas.

La base de datos fue pensada para que una farmacia pueda consultar y registrar información importante de su operación diaria. Por ejemplo, permite saber qué sucursales existen, qué personal trabaja en cada una, qué medicamentos o insumos se manejan, qué proveedores los suministran, qué clientes están registrados y cómo se relacionan las consultas médicas con sus recetas y tickets.

2. Análisis de requerimientos

A partir del caso de uso se identificó que el sistema debía guardar información de varias áreas de la farmacia. No se trataba solamente de registrar productos, sino de representar el funcionamiento completo de la cadena: sucursales, clínicas, empleados, clientes, medicamentos, proveedores, consultas y ventas.

Uno de los requerimientos principales fue registrar las sucursales de la farmacia. Para esto se consideraron datos como el nombre, dirección y teléfonos. Algunas sucursales también pueden tener una clínica integrada, por lo que se incluyó información específica de clínicas, como nombre, número de cuartos y horarios.

También se necesitó guardar información del personal. En el diseño se tomó una entidad general llamada **PERSONAL**, de la cual se desprenden distintos tipos de trabajadores, como médicos, enfermeras, cajeros, personal de limpieza, cuidadores y farmacéuticos. Esto ayudó a evitar repetir datos comunes, como nombre, RFC, domicilio, salario y sucursal donde trabaja cada persona.

Otro punto importante fue el registro de clientes. En el modelo se consideró que un cliente puede ser físico, cliente en línea o paciente. Por eso, en la tabla **CLIENTE** se agregaron atributos que permiten distinguir estos casos, además de datos personales como nombre, fecha de nacimiento, domicilio, método de pago, usuario y contraseña para compras en línea.

Para la parte médica, el sistema contempla consultas, médicos, enfermeras y recetas médicas. Cada consulta se relaciona con un cliente, un médico, una enfermera, una clínica y un ticket. Además, si la consulta genera una receta, esta se relaciona mediante una tabla especial que permite representar esa conexión.

En cuanto a medicamentos e insumos, se identificó la necesidad de registrar tanto los productos que se venden como los insumos utilizados para preparar medicamentos. También se consideraron los proveedores, ya que un mismo medicamento o insumo puede ser suministrado por más de un proveedor. Para representar esta relación, se usaron tablas intermedias como **PROVEER_MEDICAMENTO** y **PROVEER_INSUMO**.

Al final, también se consideraron tickets y compras. Un ticket se relaciona con una sucursal y un cliente, mientras que los medicamentos comprados se registran en la tabla **COMPRAR**. Así se puede saber qué cliente compró, en qué sucursal y qué medicamentos estuvieron involucrados.

3. Consideraciones de diseño

En esta sección se documentan y justifican las decisiones de diseño más relevantes tomadas durante la construcción del modelo, comparando los requerimientos del caso de uso con lo que finalmente se

implementó. Se recorren las entidades y reglas del negocio una por una, señalando dónde el modelo cubre fielmente lo solicitado y dónde se simplificó o se tomó una interpretación distinta.

3.1. Sucursal y clínica

El caso de uso solicita guardar para las sucursales: nombre, dirección completa (calle, número interior, número exterior, colonia y estado), teléfono y horarios de atención. Para las clínicas integradas pide además: nombre de la clínica, número de cuartos, número de empleados y horarios de atención.

La tabla **SUCURSAL** recoge el nombre y la dirección completa solicitados. El teléfono se modeló como atributo multivaluado en la tabla **TELEFONO_SUCURSAL**, lo que permite registrar más de un número por sucursal sin alterar la estructura principal. Los horarios de atención de las clínicas se modelaron de la misma forma en **HORARIO_CLINICA** pues pueden ser varios horarios (fines de semana, entre semana, etc.)

La primera decisión de diseño relevante fue **omitir el atributo número de empleados** de la tabla **CLINICA**. Este dato es un valor derivado: puede obtenerse en cualquier momento contando los registros de **PERSONAL** asociados a la sucursal que contiene la clínica. Almacenarlo de forma fija implicaría redundancia y el riesgo de que quedara desactualizado cada vez que el personal cambia. En su lugar, este valor se calcula dinámicamente cuando se necesita por medio de nuestros triggers explicados en el reporte general.

La relación entre sucursal y clínica se modeló con la llave foránea **CLINICA.IDSucursal** que apunta a **SUCURSAL.IDSucursal** con la acción **ON DELETE RESTRICT**. De esta manera no es posible eliminar una sucursal mientras tenga clínicas registradas, lo que protege la estructura operativa de la cadena. Esto, pues no tiene sentido que la sucursal deje de existir mientras ésta tenga clínicas registradas.

3.2. Personal y especialización

El caso de uso establece varios tipos de personal: farmacéuticos, cajeros, personal de limpieza, cuidadores y, en sucursales con clínica, médicos y enfermeras. Para todo el personal se requieren los mismos datos base: nombre completo, cédula profesional, RFC, teléfonos, correos electrónicos, horario de trabajo, domicilio y salario.

Como se vio en clase, los atributos se modelaron de la siguiente manera: La tabla **PERSONAL** almacena todos los atributos compartidos por cualquier trabajador, mientras que seis tablas especializadas (**MEDICO**, **ENFERMERA**, **CAJERO**, **LIMPIEZA**, **CUIDADOR** y **FARMACEUTICO**) extienden esa información con los atributos propios de cada rol. Cada tabla especializada usa **IDPersonal** simultáneamente como llave primaria y como llave foránea hacia **PERSONAL**, estableciendo una relación de uno a uno.

Los teléfonos, correos y horarios del personal son atributos multivaluados en el caso de uso. Se modelaron en tablas independientes como se vio en clase, (**TELEFONO_PERSONAL**, **CORREO_PERSONAL** y **HORARIO_PERSONAL**), cada una con llave primaria compuesta por **IDPersonal** más el valor del atributo. Para los **médicos**, el caso de uso pide especialidad, institución de egreso y vigencia de certificación. Los tres atributos están en la tabla **MEDICO**. Adicionalmente se agregó una restricción **CHECK** que exige que la vigencia de certificación sea igual o posterior a la fecha actual, evitando registrar médicos con certificación vencida, esto es una decisión de diseño importante para que los datos sean congruentes con los médicos que se tienen o que se intentan contratar.

Para las **enfermeras**, el caso de uso pide el tipo de procedimiento a cargo y si poseen certificación de reanimación. Ambos atributos se representan en la tabla **ENFERMERA** mediante **TipoProcedimiento** y **CertificadoReanimacion**.

3.3. Medicamentos que preparan los farmacéuticos

El caso de uso describe cinco categorías de medicamentos que los farmacéuticos pueden preparar: formulaciones, preparados oficiales, medicamentos estériles, preparaciones pediátricas y preparaciones dermatológicas.

Se decidió modelar estas categorías como **atributos booleanos** dentro de la tabla **MEDICAMENTO**: **MedicamentosEsteriles**, **PreparadosOficiales**, **Pediatrica** y **Dermatologica**. Adicionalmente se incluyeron los campos **Preparaciones** y **Formulacion** de tipo **TEXT** para describir libremente el contenido de las formulaciones.

Esta decisión simplifica notablemente las consultas de filtrado por categoría, ya que basta evaluar una bandera booleana en lugar de hacer combinaciones con tablas adicionales. La contraparte es que un medicamento puede pertenecer a varias categorías a la vez, lo cual el modelo permite de forma intencional. Si en algún momento el negocio requiriera que cada medicamento perteneciera a exactamente una categoría, la solución más apropiada sería una tabla de catálogo de categorías relacionada por llave foránea.

3.4. Insumos

El caso de uso plantea varios atributos para los insumos: nombre científico, nombre comercial, tipo, forma física, potencia, grado farmacopeico, riesgo, si es estéril, temperatura de almacenamiento, sensibilidad y observaciones.

La implementación cubrió los atributos que coinciden con la información farmacéutica de uso más frecuente, agrupándolos en la tabla **INSUMO** con los campos: **NombreCientifico** (que además funciona como llave primaria natural), **Presentacion**, **FormaFarmaceutica**, **Concentracion**, **ViaAdministracion**, **Clasificacion**, **Descripcion**, **LaboratorioFabricante**, **NombreComercial**, **TipoDeControl**, **PrecioPublico** y **PrecioUnitario**.

Los atributos más especializados de la especificación (grado farmacopeico, nivel de riesgo, condición de esterilidad, temperatura de almacenamiento, sensibilidad y observaciones) **no se modelaron como columnas independientes**. La decisión de diseño fue que el campo **Descripcion**, de tipo **TEXT**, puede absorber esa información de forma narrativa, lo que mantiene el esquema más simple y evita una gran cantidad de columnas opcionales con valores nulos. Es una simplificación válida para el alcance del proyecto, además de facilitar la obtención de conocimiento teniendo menos datos null con los que después se tendrá que trabajar.

La elección de **NombreCientifico** como llave primaria natural es adecuada en el contexto farmacológico, donde ese nombre identifica de forma única a un insumo. La consecuencia es que si el nombre cambiara, ese cambio debe propagarse a todas las tablas que lo referencian; el esquema lo maneja mediante la acción **ON UPDATE CASCADE** en las llaves foráneas correspondientes.

3.5. Clientes y tipos de cliente

El caso de uso pide registrar a los clientes con nombre completo, teléfonos, correos, fecha de nacimiento, domicilio y método de pago. Además distingue entre clientes que compren en sucursal (físicos), clientes que compren en línea (con usuario, contraseña, número de tarjeta y fecha de vencimiento) y pacientes que reciben consultas.

La decisión de diseño fue **unificar los tres tipos en una sola tabla CLIENTE** con tres indicadores booleanos: **EsClienteFisico**, **EsClienteEnLinea** y **EsPaciente**. Los atributos exclusivos del cliente en línea (**Usuario**, **Contrasena**, **NumeroTarjeta** y **VencimientoTarjeta**) quedaron como columnas opcionales que solo se llenan cuando el cliente es en línea.

Esta decisión simplifica las consultas que necesitan relacionar a los clientes con sus tickets, consultas o recetas, ya que toda la información del cliente reside en una sola tabla. La alternativa habría sido crear tres tablas especializadas, como se hizo con el personal, pero se consideró que la superposición entre tipos (un mismo cliente puede ser físico, en línea y paciente a la vez) hacía más práctica la solución de banderas booleanas.

Los teléfonos y correos del cliente se modelaron como atributos multivaluados en `TELEFONO_CLIENTE` y `CORREO_CLIENTE`, siguiendo el mismo criterio aplicado al personal.

3.6. Regla de descuentos

El caso de uso establece una regla de descuentos basada en la frecuencia de visitas de cada cliente: si acude más de 6 veces al año se le aplica un 25 %, si acude 4 veces un 10 % y si acude 2 veces un 5 %.

La implementación adoptó una **interpretación distinta** para el cálculo del descuento. En lugar de contar las visitas de cada cliente, el descuento se determina según el número total de tickets registrados en el sistema durante el año en curso. Los rangos implementados son: de 0 a 99 tickets, 0 % de descuento; de 100 a 499 tickets, 5 %; de 500 a 1999 tickets, 10 %; y de 2000 tickets o más, 15 %.

Esta diferencia respecto al caso de uso es importante y debe quedar explícita. El caso de uso plantea un descuento *personalizado por cliente*, en función de su historial individual de visitas; la implementación aplica un descuento *global*, en función del volumen total de operaciones de la cadena durante el año. Ambos son esquemas de descuentos válidos. Esta decisión se originó en el desarrollo de las prácticas del semestre y se conservó en el proyecto final por consistencia con el resto de los componentes ya construidos sobre ella, en particular los disparadores que calculan los importes del ticket. Además de que es mucho más sensato generar descuento a partir de las veces que compras en la tienda que de las veces que te paras ahí sin generar nada a La Farmacia de Otro Mundo.

3.7. Consultas médicas

El caso de uso pide guardar para cada consulta: la fecha y hora en que se realizó, el médico que la realizó, la enfermera que apoyó, el cliente que fue atendido y el diagnóstico. También indica que, cuando el cliente pague la consulta, debe guardarse su precio.

La tabla `CONSULTA` incluye todos estos atributos. El precio se almacena en `CostoConsulta`, con una restricción `CHECK` que impide valores negativos. La enfermera se modeló como participación opcional: `IDEnfermera` admite nulos y su llave foránea usa la acción `ON DELETE SET NULL`, en coherencia con la descripción del caso de uso, que presenta a la enfermera como un apoyo que puede o no estar presente.

Una decisión de diseño relevante fue **ligar cada consulta a un ticket** mediante `CONSULTA.IDTicket` y forzar que esa relación sea uno a uno con una restricción `UNIQUE` sobre `IDTicket`. Esto modela la regla de que una consulta genera exactamente un cobro, registrado en el ticket correspondiente, tal como lo plantea la especificación cuando indica que la consulta debe pagarse en la sucursal.

Las llaves foráneas de `CONSULTA` apuntan a las tablas `MEDICO` y `ENFERMERA`, no directamente a `PERSONAL`. Con ello se garantiza, a nivel de base de datos, que solo personal con el rol adecuado pueda quedar registrado como responsable o apoyo de una consulta.

3.8. Recetas médicas

El caso de uso pide guardar en las recetas una lista amplia de datos: nombre del paciente, edad, fecha de nacimiento, peso, talla, número de receta, identificador del paciente, alergias reportadas, diagnóstico, nombre del médico, cédula profesional del médico, especialidad, consultorio, turno, los medicamentos recetados, su forma farmacéutica, concentración, presentación, dosis prescrita, frecuencia, vía de administración y duración o número de días.

La implementación distribuyó esta información en dos tablas: **RECETA_MEDICA** para el encabezado de la receta y **PEDIR** para el detalle de los medicamentos.

La tabla **RECETA_MEDICA** almacena **FechaNacimiento**, **Peso**, **Talla**, **Alergias**, **Diagnostico**, **Consultorio** y **Turno**. Sobre ella se aplicaron varias decisiones de simplificación, todas orientadas a evitar redundancia:

- El **nombre del paciente** no se almacena en la receta, porque puede obtenerse con la relación que une la receta con su consulta y la consulta con el cliente. Guardarlo en la receta sería duplicar un dato que ya existe.
- El **nombre y la cédula del médico** tampoco se almacenan en la receta, por la misma razón: se obtienen a través de la consulta y de la especialización **MEDICO**. La especificación los menciona porque en una receta impresa deben aparecer físicamente, pero en la base de datos preferimos simplemente referenciarlos en lugar de duplicarlos.
- La **edad** del paciente no se guarda como columna, ya que es un valor derivado de la fecha de nacimiento; se calcula cuando se necesita por medio de nuestros triggers.
- La **duración o número de días** del tratamiento no se incluyó como columna independiente en **PEDIR**. Esta información puede incorporarse dentro de los campos **Frecuencia** o **Dosis** como texto, lo que es una simplificación razonable para el alcance del proyecto.

La tabla **PEDIR** representa la relación muchos a muchos entre una receta y los medicamentos que indica, e incluye **Dosis** y **Frecuencia** como atributos propios de esa relación. Los atributos de forma farmacéutica, concentración, presentación y vía de administración no se repiten en **PEDIR** porque ya están disponibles en las tablas de los productos referenciados.

La relación entre consulta y receta se implementó mediante la tabla **GENERAR_CONSULTA_RECETA**, con restricciones **UNIQUE** sobre ambas llaves foráneas. Esto garantiza la cardinalidad uno a uno: una consulta genera a lo más una receta y una receta proviene de a lo más una consulta.

3.9. Medicamentos

El caso de uso pide para los medicamentos: nombre comercial, nombre genérico, forma farmacéutica, concentración o potencia, presentación, vía de administración, clasificación, tipo de control, laboratorio fabricante, descripción y stock disponible.

La tabla **MEDICAMENTO** cubre el stock, los precios público y unitario, y las categorías de preparación especial descritas anteriormente. Sin embargo, varios atributos puramente descriptivos (nombre comercial, nombre genérico, forma farmacéutica, concentración, presentación, vía de administración, clasificación, tipo de control, laboratorio y descripción) **no se modelaron como columnas independientes en MEDICAMENTO**.

La razón de esta decisión es que, en el modelo implementado, los medicamentos que vende la farmacia y los insumos con los que se preparan comparten una estructura descriptiva muy parecida. Esa estructura descriptiva se concentró en la tabla **INSUMO**, y la relación **UTILIZAR** conecta cada medicamento con los insumos que lo componen. De este modo se evita duplicar la misma estructura descriptiva en dos tablas distintas.

3.10. Proveedores

El caso de uso pide para los proveedores: número, razón social, los medicamentos e insumos que provee, dirección y teléfonos. También establece de forma expresa que un mismo medicamento o insumo puede ser proporcionado por más de un proveedor, y que para cada suministro deben conocerse la fecha de recibo, la fecha de caducidad, las condiciones de almacenamiento, el precio unitario y el precio público.

La tabla **PROVEEDOR** cubre la razón social y la dirección completa. El teléfono se modeló como atributo multivaluado en **TELEFONO_PROVEEDOR**.

La relación entre proveedor, medicamento y sucursal se modeló como una **relación ternaria** en la tabla **PROVEER_MEDICAMENTO**, que incluye, además de los tres participantes, la condición de almacenamiento, la cantidad, la fecha de recibo y la fecha de caducidad. Esta estructura permite registrar que un mismo proveedor entrega distintos medicamentos a distintas sucursales en distintas fechas. Para distinguir cada entrega (cada lote), la llave primaria compuesta incluye la fecha de recibo.

La misma estructura ternaria se repite en **PROVEER_INSUMO** para los insumos.

Esta decisión satisface directamente el requerimiento de que un medicamento pueda tener varios proveedores, y como beneficio adicional permite rastrear el historial de entregas por sucursal, lo que resulta valioso para el control del inventario y la gestión de caducidades.

3.11. Tickets

El caso de uso indica que en el ticket debe aparecer: la sucursal donde se realizó la compra, los medicamentos comprados (si los hubo), la consulta realizada (si la hubo), el precio bruto y el precio neto después de aplicar descuentos.

La tabla **TICKET** contiene la sucursal, el cliente, la fecha, la hora, el precio bruto, el precio neto y el descuento aplicado. Los medicamentos comprados se registran en la tabla **COMPRAR**, y la consulta asociada se vincula a través de **CONSULTA.IDTicket**.

El precio bruto y el precio neto se mantienen actualizados de forma automática mediante los disparadores definidos en el proyecto, de manera que siempre reflejan el estado actual de los productos asociados al ticket sin necesidad de cálculos manuales.

Una consideración técnica que conviene dejar registrada es que el precio neto, dentro de los disparadores, se calcula aplicando el porcentaje de descuento almacenado en el ticket, sin incluir IVA. En contraste, algunas consultas de análisis del proyecto calculan un precio neto aplicando un IVA del 16 % como criterio alternativo. Ambos cálculos son válidos en sus respectivos contextos (uno es el importe que efectivamente se almacena en el ticket y el otro es un cálculo analítico para una consulta específica), pero es importante tenerlo presente al interpretar los resultados para no confundir ambas cifras.

3.12. Control de inventario

El caso de uso establece que debe conocerse el stock disponible de cada medicamento, con el fin de poder solicitar reabastecimiento a los proveedores cuando sea necesario.

La columna **Stock** de la tabla **MEDICAMENTO** cumple esa función, y su valor se mantiene actualizado de forma automática mediante tres disparadores que reaccionan a los movimientos de inventario:

- Cuando un proveedor entrega medicamento, el stock aumenta.
- Cuando un farmacéutico prepara medicamento, el stock aumenta.
- Cuando un cliente realiza una compra, el stock disminuye, previa validación que impide que el inventario quede en valores negativos.

Los tres disparadores contemplan también las operaciones de actualización y eliminación, revirtiendo el efecto del valor anterior antes de aplicar el nuevo. Con ello el inventario permanece exacto incluso ante correcciones de captura o cancelaciones.

3.13. Compra en línea

El caso de uso establece que los clientes pueden comprar medicamentos o insumos en línea, siempre que no se necesite receta; que para ello deben iniciar sesión con usuario y contraseña; que al realizar una compra en línea se guardan el número de tarjeta y su fecha de vencimiento para futuras compras; y que esa operación también genera un ticket, equivalente al de una compra presencial.

En el modelo, los atributos *Usuario*, *Contraseña*, *NumeroTarjeta* y *VencimientoTarjeta* residen en la tabla **CLIENTE** como columnas opcionales que se utilizan cuando el cliente es en línea. El ticket no distingue estructuralmente entre una compra presencial y una en línea; la naturaleza de la venta se infiere a partir del tipo de cliente asociado al ticket. Esta decisión permite, sin embargo, clasificar y comparar ambas modalidades en las consultas de análisis del proyecto.

La restricción del caso de uso según la cual los productos comprados en línea no deben requerir receta **no se forzó a nivel de base de datos**: no existe una restricción que impida asociar a un ticket en línea un medicamento de venta bajo receta. Esa validación se asume responsabilidad de la capa de aplicación, lo que se documenta aquí como una decisión consciente y como un posible punto de refuerzo futuro.

3.14. Decisiones generales de integridad

Acciones referenciales diferenciadas. Las llaves foráneas no usan una sola política uniforme, sino que se eligió la acción adecuada según el significado de cada relación. Se utilizó borrado en cascada para los datos que no tienen sentido sin su entidad principal (como los teléfonos y correos de un cliente, o las especializaciones de un trabajador) y borrado restringido para las entidades cuya eliminación pondría en riesgo información histórica valiosa (como una sucursal con personal, o un medicamento con compras registradas). Para la participación opcional de la enfermera en una consulta se utilizó la acción de poner el valor en nulo.

Orden de carga deliberado. Se estableció que los disparadores se instalen antes de insertar los datos de prueba, con el fin de que su funcionamiento se verifique desde el inicio del poblamiento y de que los valores derivados (como el stock y los importes de los tickets) se calculen correctamente desde la primera inserción.

El conjunto de decisiones aquí documentadas refleja un equilibrio entre dos objetivos: por un lado, ser fiel a los requerimientos del caso de uso *Una farmacia de otro mundo* y, por otro, mantener un esquema claro, consistente y libre de redundancias innecesarias, además de facilitar la implementación de todo lo que pedía el cliente con un modelo efectivo que aterrice lo que el cliente pide con lo que nosotros podemos ofrecerle.

En la mayoría de las entidades el modelo cubre fielmente lo solicitado, y en varios puntos lo refuerza con restricciones de integridad que la especificación no exigía de forma explícita. Las diferencias más significativas respecto al caso de uso son dos: la regla de descuentos, que se implementó por volumen global de tickets en lugar de por visitas individuales del cliente (ya se explicó el por qué), y el control automático de inventario, que se desarrolló de forma más completa para medicamentos que para insumos. Ambas diferencias se documentan de manera transparente para que el lector comprenda el alcance real del sistema entregado.

4. Modelo Entidad–Relación

El modelo Entidad–Relación se desarrolló con el objetivo de representar de manera gráfica y conceptual el funcionamiento general de la cadena de farmacias descrita en el caso de uso. A partir del análisis de requerimientos y las consideraciones de diseño se identificaron las entidades principales, sus

atributos y las relaciones existentes entre ellas, buscando que el modelo reflejara las reglas de negocio más importantes del sistema.

Dentro del modelo se consideraron entidades principales como **CLIENTE**, **SUCURSAL**, **PERSONAL**, **MEDICAMENTO**, **INSUMO**, **PROVEEDOR**, **CONSULTA**, **RECETA_MEDICA**, **CLINICA** y **TICKET**. Estas entidades representan los componentes esenciales de la operación diaria de la farmacia y permiten organizar la información de forma estructurada.

Uno de los aspectos más importantes del modelo fue el manejo de la entidad **PERSONAL** como una superentidad. A partir de ella se derivan entidades especializadas como **MEDICO**, **ENFERMERA**, **FARMACEUTICO**, **CAJERO**, **LIMPIEZA** y **CUIDADOR**. Esta decisión permitió reutilizar atributos comunes como nombre, RFC, salario, domicilio y sucursal asignada, evitando redundancia y facilitando la administración de distintos tipos de empleados.

También se identificaron relaciones de distintos tipos. Por ejemplo, existen relaciones uno-a-muchos entre **SUCURSAL** y **PERSONAL**, ya que una sucursal puede tener muchos empleados, pero cada empleado pertenece únicamente a una sucursal. De forma similar, un cliente puede tener múltiples tickets o consultas médicas asociadas.

Además, se modelaron relaciones muchos-a-muchos mediante entidades intermedias. Un ejemplo es la relación entre **PROVEEDOR** y **MEDICAMENTO**, ya que un proveedor puede suministrar muchos medicamentos y un medicamento puede ser surtido por distintos proveedores. Para representar correctamente esta situación se utilizaron entidades asociativas como **PROVEER_MEDICAMENTO** y **PROVEER_INSUMO**.

En la parte médica, el modelo permite relacionar consultas con médicos, enfermeras, pacientes y recetas médicas. Esto permite representar el flujo completo de atención dentro de la clínica integrada a la farmacia. Asimismo, la relación entre **CONSULTA** y **RECETA_MEDICA** permite asociar recetas generadas durante una consulta específica.

Otro aspecto importante fue el manejo de atributos multivaluados, como teléfonos y correos electrónicos. En lugar de almacenar varios valores en una misma columna, se optó por modelarlos mediante entidades independientes relacionadas con clientes, sucursales o personal, siguiendo una estructura más normalizada.

En general, el modelo Entidad-Relación sirvió como base conceptual para posteriormente construir el modelo relacional y la implementación física en PostgreSQL. Gracias a este diseño fue posible representar de manera clara las entidades principales del sistema, sus relaciones y las restricciones necesarias para mantener la integridad de la información.

5. Modelo Relacional

Una vez definido el modelo Entidad-Relación, se realizó su traducción al modelo relacional con el objetivo de implementar la base de datos dentro del manejador PostgreSQL. Durante este proceso se transformaron las entidades en tablas, las relaciones en llaves foráneas y las relaciones muchos-a-muchos en tablas intermedias.

El diseño relacional se desarrolló buscando reducir redundancia de información, mantener integridad referencial y facilitar la ejecución de consultas sobre el sistema. Para ello se definieron llaves primarias en cada tabla y llaves foráneas para representar las relaciones existentes entre las entidades del modelo conceptual.

Las entidades principales del sistema se implementaron como tablas independientes, entre ellas **CLIENTE**, **SUCURSAL**, **PERSONAL**, **MEDICAMENTO**, **INSUMO**, **CONSULTA**, **RECETA_MEDICA**, **PROVEEDOR** y **TICKET**.

Las especializaciones de la entidad **PERSONAL**, como **MEDICO**, **ENFERMERA**, **FARMACEUTICO**, **CAJERO**, **LIMPIEZA** y **CUIDADOR**, se implementaron mediante tablas separadas que reutilizan la llave primaria de la superentidad. Esto permitió conservar una relación uno-a-uno entre cada empleado y su especialización correspondiente.

Asimismo, las relaciones muchos–a–muchos se implementaron mediante tablas intermedias. Por ejemplo, las relaciones entre proveedores y medicamentos, o entre tickets y medicamentos comprados, se representaron mediante tablas como `PROVEER_MEDICAMENTO`, `PROVEER_INSUMO` y `COMPRAR`.

También se implementaron tablas para atributos multivaluados, como teléfonos, horarios y correos electrónicos, permitiendo almacenar múltiples valores asociados a una misma entidad sin duplicar información.

Finalmente, el modelo relacional incorporó restricciones de integridad como llaves primarias, llaves foráneas, restricciones `NOT NULL`, `CHECK`, `UNIQUE` y valores por defecto, con el objetivo de asegurar consistencia y validez en los datos almacenados.

6. Dependencias funcionales

A continuación se presentan las dependencias funcionales de la base de datos, obtenidas principalmente del DDL, ya que las dependencias funcionales deben salir de las restricciones del esquema: llaves primarias, llaves únicas y reglas estructurales.

El propio DDL indica que las entidades fuertes tienen `PRIMARY KEY`, que las especializaciones usan `IDPersonal`, y que las relaciones multivaluadas, muchos a muchos y ternarias usan llaves compuestas. Además, se declaran restricciones `UNIQUE` como `Usuario`, `RFC`, `IDTicket` en `CONSULTA`, e identificadores únicos en `GENERAR_CONSULTA_RECETA`.

1. CLIENTE

`CLIENTE`(*IDCliente*, *Nombre*, *ApellidoPaterno*, *ApellidoMaterno*,
FechaNacimiento, *Calle*, *NumExterior*, *NumInterior*, *Colonia*, *Estado*,
MetodoPago, *NumeroTarjeta*, *VencimientoTarjeta*, *Usuario*, *Contrasena*,
EsClienteEnLinea, *EsClienteFisico*, *EsPaciente*)

Llave primaria:

IDCliente

Dependencia funcional principal:

IDCliente → *Nombre*, *ApellidoPaterno*, *ApellidoMaterno*, *FechaNacimiento*,
Calle, *NumExterior*, *NumInterior*, *Colonia*, *Estado*, *MetodoPago*,
NumeroTarjeta, *VencimientoTarjeta*, *Usuario*, *Contrasena*,
EsClienteEnLinea, *EsClienteFisico*, *EsPaciente*

2. SUCURSAL

`SUCURSAL`(*IDSucursal*, *Nombre*, *Calle*, *NumExterior*,
NumInterior, *Colonia*, *Estado*)

Llave primaria:

IDSucursal

Dependencia funcional:

$$IDSucursal \rightarrow Nombre, Calle, NumExterior, NumInterior, Colonia, Estado$$

3. PROVEEDOR

$$\text{PROVEEDOR}(IDProveedor, RazonSocial, Calle, NumExterior, \\ NumInterior, Colonia, Estado)$$

Llave primaria:

$$IDProveedor$$

Dependencia funcional:

$$IDProveedor \rightarrow RazonSocial, Calle, NumExterior, NumInterior, Colonia, Estado$$

4. PERSONAL

$$\text{PERSONAL}(IDPersonal, IDSucursal, Nombre, ApellidoPaterno, \\ ApellidoMaterno, CedulaProfesional, RFC, Calle, NumExterior, \\ NumInterior, Colonia, Estado, Salario)$$

Llave primaria:

$$IDPersonal$$

Dependencia funcional principal:

$$IDPersonal \rightarrow IDSucursal, Nombre, ApellidoPaterno, ApellidoMaterno, \\ CedulaProfesional, RFC, Calle, NumExterior, NumInterior, \\ Colonia, Estado, Salario$$

5. CORREO_CLIENTE

$$\text{CORREO_CLIENTE}(IDCliente, CorreoElectronico)$$

Llave primaria compuesta:

$$(IDCliente, CorreoElectronico)$$

No hay dependencias funcionales no triviales adicionales. La llave solo evita que se repita el mismo correo para el mismo cliente.

No se debe asumir:

$$IDCliente \rightarrow CorreoElectronico$$

porque un cliente puede tener varios correos.

6. TELEFONO_CLIENTE

$\text{TELEFONO_CLIENTE}(ID\text{Cliente}, \text{Telefono})$

Llave primaria compuesta:

$(ID\text{Cliente}, \text{Telefono})$

No hay dependencias funcionales no triviales adicionales.

No se debe asumir:

$ID\text{Cliente} \rightarrow \text{Telefono}$

porque un cliente puede tener varios teléfonos.

7. TELEFONO_PROVEEDOR

$\text{TELEFONO_PROVEEDOR}(ID\text{Proveedor}, \text{Telefono})$

Llave primaria compuesta:

$(ID\text{Proveedor}, \text{Telefono})$

No hay dependencias funcionales no triviales adicionales.

No se debe asumir:

$ID\text{Proveedor} \rightarrow \text{Telefono}$

porque un proveedor puede tener varios teléfonos.

8. INSUMO

$\text{INSUMO}(\text{NombreCientifico}, \text{Presentacion}, \text{FormaFarmaceutica},$
 $\text{Concentracion}, \text{ViaAdministracion}, \text{Clasificacion}, \text{Descripcion},$
 $\text{LaboratorioFabricante}, \text{NombreComercial}, \text{TipoDeControl},$
 $\text{PrecioPublico}, \text{PrecioUnitario})$

Llave primaria:

NombreCientifico

Dependencia funcional:

$\text{NombreCientifico} \rightarrow \text{Presentacion}, \text{FormaFarmaceutica}, \text{Concentracion},$
 $\text{ViaAdministracion}, \text{Clasificacion}, \text{Descripcion}, \text{LaboratorioFabricante},$
 $\text{NombreComercial}, \text{TipoDeControl}, \text{PrecioPublico}, \text{PrecioUnitario}$

9. HORARIO_PERSONAL

$\text{HORARIO_PERSONAL}(IDPersonal, Horario)$

Llave primaria compuesta:

$(IDPersonal, Horario)$

No hay dependencias funcionales no triviales adicionales.

No se debe asumir:

$IDPersonal \rightarrow Horario$

porque un trabajador puede tener varios horarios.

10. CORREO_PERSONAL

$\text{CORREO_PERSONAL}(IDPersonal, CorreoElectronico)$

Llave primaria compuesta:

$(IDPersonal, CorreoElectronico)$

No hay dependencias funcionales no triviales adicionales.

No se debe asumir:

$IDPersonal \rightarrow CorreoElectronico$

porque un integrante del personal puede tener varios correos.

11. TELEFONO_PERSONAL

$\text{TELEFONO_PERSONAL}(IDPersonal, Telefono)$

Llave primaria compuesta:

$(IDPersonal, Telefono)$

No hay dependencias funcionales no triviales adicionales.

No se debe asumir:

$IDPersonal \rightarrow Telefono$

porque un integrante del personal puede tener varios teléfonos.

12. MEDICO

$\text{MEDICO}(\text{IDPersonal}, \text{Especialidad}, \text{InstitucionEgreso}, \text{VigenciaCertificacion})$

Llave primaria:

IDPersonal

Dependencia funcional:

$\text{IDPersonal} \rightarrow \text{Especialidad}, \text{InstitucionEgreso}, \text{VigenciaCertificacion}$

13. ENFERMERA

$\text{ENFERMERA}(\text{IDPersonal}, \text{CertificadoReanimacion}, \text{TipoProcedimiento})$

Llave primaria:

IDPersonal

Dependencia funcional:

$\text{IDPersonal} \rightarrow \text{CertificadoReanimacion}, \text{TipoProcedimiento}$

14. CAJERO

$\text{CAJERO}(\text{IDPersonal})$

Llave primaria:

IDPersonal

No hay dependencias funcionales no triviales, porque la tabla solo contiene la llave.

15. LIMPIEZA

$\text{LIMPIEZA}(\text{IDPersonal})$

Llave primaria:

IDPersonal

No hay dependencias funcionales no triviales.

16. CUIDADOR

$\text{CUIDADOR}(\text{IDPersonal})$

Llave primaria:

IDPersonal

No hay dependencias funcionales no triviales.

17. FARMACEUTICO

FARMACEUTICO(*IDPersonal*)

Llave primaria:

IDPersonal

No hay dependencias funcionales no triviales.

18. CLINICA

CLINICA(*IDClinica*, *IDSucursal*, *Nombre*, *NumCuartos*)

Llave primaria:

IDClinica

Dependencia funcional:

$IDClinica \rightarrow IDSucursal, Nombre, NumCuartos$

19. HORARIO_CLINICA

HORARIO_CLINICA(*IDClinica*, *Horario*)

Llave primaria compuesta:

$(IDClinica, Horario)$

No hay dependencias funcionales no triviales adicionales.

No se debe asumir:

$IDClinica \rightarrow Horario$

porque una clínica puede tener varios horarios.

20. TELEFONO_SUCURSAL

TELEFONO_SUCURSAL(*IDSucursal*, *Telefono*)

Llave primaria compuesta:

$(IDSucursal, Telefono)$

No hay dependencias funcionales no triviales adicionales.

No se debe asumir:

$IDSucursal \rightarrow Telefono$

porque una sucursal puede tener varios teléfonos.

21. MEDICAMENTO

MEDICAMENTO(*IDMedicamento, PrecioPublico, PrecioUnitario, MedicamentosEsteriles, Preparaciones, Formulacion, PreparadosOficiales, Pediatrica, Dermatologica, Stock*)

Llave primaria:

IDMedicamento

Dependencia funcional:

IDMedicamento → *PrecioPublico, PrecioUnitario, MedicamentosEsteriles, Preparaciones, Formulacion, PreparadosOficiales, Pediatrica, Dermatologica, Stock*

22. PROVEER_MEDICAMENTO

PROVEER_MEDICAMENTO(*IDProveedor, IDMedicamento, IDSucursal, CondicionDeAlmacenamiento, Cantidad, FechaDeRecibo, FechaDeCaducidad*)

Llave primaria compuesta:

(IDProveedor, IDMedicamento, IDSucursal, FechaDeRecibo)

Dependencia funcional:

IDProveedor, IDMedicamento, IDSucursal, FechaDeRecibo → *CondicionDeAlmacenamiento, Cantidad, FechaDeCaducidad*

Aquí *FechaDeRecibo* forma parte de la llave porque distingue los lotes recibidos.

23. PROVEER_INSUMO

PROVEER_INSUMO(*IDProveedor, IDSucursal, NombreCientifico, CondicionDeAlmacenamiento, Cantidad, FechaDeRecibo, FechaDeCaducidad*)

Llave primaria compuesta:

(IDProveedor, IDSucursal, NombreCientifico, FechaDeRecibo)

Dependencia funcional:

IDProveedor, IDSucursal, NombreCientifico, FechaDeRecibo → *CondicionDeAlmacenamiento, Cantidad, FechaDeCaducidad*

24. PREPARAR

$\text{PREPARAR}(IDMedicamento, IDPersonal, Cantidad)$

Llave primaria compuesta:

$(IDMedicamento, IDPersonal)$

Dependencia funcional:

$IDMedicamento, IDPersonal \rightarrow Cantidad$

25. USAR

$\text{USAR}(IDPersonal, NombreCientifico)$

Llave primaria compuesta:

$(IDPersonal, NombreCientifico)$

No hay dependencias funcionales no triviales adicionales.

26. UTILIZAR

$\text{UTILIZAR}(IDMedicamento, NombreCientifico)$

Llave primaria compuesta:

$(IDMedicamento, NombreCientifico)$

No hay dependencias funcionales no triviales adicionales.

No se debe asumir:

$IDMedicamento \rightarrow NombreCientifico$

porque un medicamento puede utilizar varios insumos.

Tampoco se debe asumir:

$NombreCientifico \rightarrow IDMedicamento$

porque un insumo puede ser usado por varios medicamentos.

27. TICKET

$\text{TICKET}(IDTicket, IDSucursal, IDCliente, Fecha, Hora, PrecioBruto, PrecioNeto, DescuentoAplicado)$

Llave primaria:

$IDTicket$

Dependencia funcional:

$$IDTicket \rightarrow IDSucursal, IDCliente, Fecha, Hora, \\ PrecioBruto, PrecioNeto, DescuentoAplicado$$

28. COMPRAR

$$COMPRAR(IDTicket, IDMedicamento, Cantidad)$$

Llave primaria compuesta:

$$(IDTicket, IDMedicamento)$$

Dependencia funcional:

$$IDTicket, IDMedicamento \rightarrow Cantidad$$

Esto significa que, dentro de un mismo ticket, un medicamento aparece una sola vez con una cantidad asociada.

29. CONSULTA

$$CONSULTA(IDConsulta, IDCliente, IDMedico, IDEnfermera, \\ IDClinica, IDTicket, Fecha, Hora, Diagnostico, CostoConsulta)$$

Llave primaria:

$$IDConsulta$$

Dependencia funcional principal:

$$IDConsulta \rightarrow IDCliente, IDMedico, IDEnfermera, IDClinica, IDTicket, \\ Fecha, Hora, Diagnostico, CostoConsulta$$

Además, el DDL declara que **IDTicket** es único en **CONSULTA**, para mantener una relación 1:1 entre ticket y consulta. Por eso también se tiene:

$$IDTicket \rightarrow IDConsulta, IDCliente, IDMedico, IDEnfermera, \\ IDClinica, Fecha, Hora, Diagnostico, CostoConsulta$$

30. RECETA_MEDICA

$$RECETA_MEDICA(NumeroReceta, FechaNacimiento, Peso, Talla, \\ Alergias, Diagnostico, Consultorio, Turno)$$

Llave primaria:

$$NumeroReceta$$

Dependencia funcional:

$$NumeroReceta \rightarrow FechaNacimiento, Peso, Talla, Alergias, \\ Diagnostico, Consultorio, Turno$$

31. PEDIR

$\text{PEDIR}(\text{NumeroReceta}, \text{IDMedicamento}, \text{Dosis}, \text{Frecuencia})$

Llave primaria compuesta:

$(\text{NumeroReceta}, \text{IDMedicamento})$

Dependencia funcional:

$\text{NumeroReceta}, \text{IDMedicamento} \rightarrow \text{Dosis}, \text{Frecuencia}$

32. GENERAR_CONSULTA_RECETA

$\text{GENERAR_CONSULTA_RECETA}(\text{IDConsulta}, \text{NumeroReceta})$

Llave primaria compuesta:

$(\text{IDConsulta}, \text{NumeroReceta})$

Pero además el DDL declara unicidad para **IDConsulta** y para **NumeroReceta**, con la intención de asegurar una relación 1:1 entre consulta y receta. Por lo tanto, las dependencias funcionales importantes son:

$\text{IDConsulta} \rightarrow \text{NumeroReceta}$

$\text{NumeroReceta} \rightarrow \text{IDConsulta}$

La dependencia de la llave compuesta:

$\text{IDConsulta}, \text{NumeroReceta} \rightarrow \text{IDConsulta}, \text{NumeroReceta}$

es trivial, por eso las dependencias realmente útiles son las dos anteriores.

Relaciones sin dependencias funcionales no triviales

Las siguientes relaciones no tienen dependencias funcionales no triviales adicionales, porque sus atributos forman únicamente una llave compuesta o solo contienen la llave:

$\text{CORREO_CLIENTE}, \text{TELEFONO_CLIENTE}, \text{TELEFONO_PROVEEDOR},$
 $\text{HORARIO_PERSONAL}, \text{CORREO_PERSONAL}, \text{TELEFONO_PERSONAL},$
 $\text{HORARIO_CLINICA}, \text{TELEFONO_SUCURSAL}, \text{CAJERO},$
 $\text{LIMPIEZA}, \text{CUIDADOR}, \text{FARMACEUTICO},$
 $\text{USAR}, \text{UTILIZAR}$

7. Implementación física en PostgreSQL

La implementación física del esquema se realizó sobre el manejador **PostgreSQL** y quedó contenida en el archivo `DDL.sql`. Este archivo traduce el modelo relacional a un conjunto de instrucciones del Lenguaje de Definición de Datos (DDL) que crean las tablas, las llaves primarias, las llaves foráneas y las restricciones de integridad necesarias para que la base de datos refleje fielmente las reglas de negocio del caso de uso *Una farmacia de otro mundo*.

El esquema físico está compuesto por **32 tablas** que se pueden agrupar en cuatro categorías: entidades fuertes, especializaciones de la entidad **PERSONAL**, tablas de atributos multivaluados y tablas que representan relaciones (binarias muchos-a-muchos, ternarias y relaciones uno-a-uno). La organización del archivo sigue un orden lógico que facilita su ejecución desde cero: primero se eliminan las tablas existentes, después se crean todas las tablas, posteriormente se agregan las restricciones de dominio, las llaves primarias y, por último, las llaves foráneas.

7.1. Estrategia de creación y limpieza del esquema

El archivo inicia con una instrucción `DROP TABLE IF EXISTS ... CASCADE` que elimina todas las tablas del esquema en caso de que ya existan de forma cascada, que como se vio en clase y laboratorios, una vez que borras al padre, se borra a todos sus hijos. Esta decisión permite que el script `DDL.sql` se pueda ejecutar varias veces seguidas sin generar errores por objetos duplicados. Note que aseguramos la integridad de los datos a la hora de eliminar en forma de cascada.

Luego entonces, las tablas se crean con instrucciones `CREATE TABLE` en las que, en una primera etapa, se declaran únicamente las columnas con sus tipos de dato. Las restricciones (`NOT NULL`, `CHECK`, `UNIQUE`, llaves primarias y llaves foráneas) se agregan después con `ALTER TABLE`.

7.2. Selección de tipos de dato

Para cada atributo se eligió un tipo de dato específico a su contexto y lo que íbamos a necesitar saber de ellos. Los identificadores de las entidades fuertes se definieron como `INT`. Los nombres, direcciones y demás textos de longitud acotada se modelaron con `VARCHAR` de tamaño adecuado a cada caso (por ejemplo, `VARCHAR(80)` para nombres, `VARCHAR(13)` para el RFC y `VARCHAR(8)` para la cédula profesional, etc.). Los campos que no sabíamos qué tan largos podían ser, como `Diagnostico`, `Preparaciones` o `Formulacion`, se definieron con el tipo `TEXT`.

Los valores monetarios se modelaron con `DECIMAL` para conservar la precisión exacta requerida en cálculos de dinero: `DECIMAL(10,2)` para precios individuales y `DECIMAL(12,2)` para los totales del ticket, donde puede acumularse un importe mayor, todo esto, de acuerdo a lo visto en el laboratorio con Ricardo. El porcentaje de descuento se definió como `DECIMAL(5,2)`, suficiente para representar valores entre 0 y 100 con dos decimales. Las fechas se modelaron con `DATE` y las horas con `TIME`. Por último, las características booleanas de clientes y medicamentos (por ejemplo, `EsClienteEnLinea`, `EsPaciente`, `MedicamentosEsteriles` o `Pediatrica`) se modelaron con el tipo `BOOLEAN`, que expresa de forma natural la presencia o ausencia de una propiedad.

7.3. Integridad de entidad: llaves primarias

Cada tabla cuenta con una llave primaria que garantiza que no existan registros duplicados y que cada fila pueda identificarse de manera única. La estrategia para definir las llaves primarias dependió del tipo de tabla:

- **Entidades fuertes.** Las tablas `CLIENTE`, `SUCURSAL`, `PROVEEDOR`, `PERSONAL`, `MEDICAMENTO`, `CLINICA`, `TICKET`, `CONSULTA` y `RECETA_MEDICA` utilizan una llave primaria simple sobre su identificador pro-

pio. La tabla `INSUMO` es un caso particular, pues utiliza el atributo natural `NombreCientifico` como llave primaria, esto pues sabemos que el nombre científico del insumo no puede ser nulo y, sobre todo, no se puede repetir.

- **Especializaciones de PERSONAL.** Las tablas `MEDICO`, `ENFERMERA`, `CAJERO`, `LIMPIEZA`, `CUIDADOR` y `FARMACEUTICO` usan `IDPersonal` como llave primaria. De esta forma, cada especialización comparte el mismo identificador de la entidad general, lo que asegura una correspondencia uno-a-uno entre un trabajador y su rol.
- **Atributos multivaluados.** Las tablas como `TELEFONO_CLIENTE`, `CORREO_CLIENTE`, `HORARIO_PERSONAL` o `TELEFONO_SUCURSAL` usan una llave primaria compuesta formada por el identificador de la entidad y el valor del atributo. Esto permite almacenar varios teléfonos, correos u horarios para una misma entidad, evitando al mismo tiempo que se repita el mismo valor para una misma entidad.
- **Relaciones muchos-a-muchos.** Las tablas `COMPRAR`, `PEDIR`, `PREPARAR`, `USAR` y `UTILIZAR` usan una llave primaria compuesta por los identificadores de las dos entidades que relacionan.
- **Relaciones ternarias.** Las tablas `PROVEER_MEDICAMENTO` y `PROVEER_INSUMO` utilizan una llave primaria compuesta que incluye, además de los participantes de la relación, la `FechaDeRecibo`. Esto permite distinguir distintos lotes entregados por un mismo proveedor a una misma sucursal en fechas diferentes.

7.4. Integridad de dominio: NOT NULL, CHECK, UNIQUE y DEFAULT

Para garantizar que los datos almacenados sean válidos y coherentes, se declararon distintas restricciones de dominio sobre las columnas:

- **NOT NULL.** Se aplicó a los atributos obligatorios, como el nombre y los apellidos de clientes y personal, la fecha de nacimiento del cliente, el RFC y el salario del personal, o el nombre de la sucursal. Con esto se evita registrar entidades incompletas.
- **CHECK.** Se utilizaron para validar reglas de dominio más específicas. Algunos ejemplos importantes son: la fecha de nacimiento no puede ser futura; el RFC debe tener exactamente 13 caracteres y la cédula profesional entre 7 y 8; el salario, los precios y el stock no pueden ser negativos; el número de cuartos de una clínica debe ser mayor que cero; la fecha de caducidad de un lote debe ser posterior a su fecha de recibo; el descuento de un ticket debe estar entre 0 y 100; y el precio neto del ticket no puede ser mayor que el precio bruto.
- **UNIQUE.** Se aplicó al atributo `Usuario` de `CLIENTE` y al `RFC` de `PERSONAL`, garantizando su unicidad natural. También se usó sobre `IDTicket` en `CONSULTA` y sobre `IDConsulta` y `NumeroReceta` en la tabla `GENERAR_CONSULTA_RECETA`, con el fin de reforzar las cardinalidades uno-a-uno entre consulta, ticket y receta.
- **DEFAULT.** Se definieron valores por defecto para campos booleanos (inicializados en `FALSE`), para las fechas y horas del ticket (`CURRENT_DATE` y `CURRENT_TIME`), para los importes del ticket (inicializados en 0) y para el stock inicial de un medicamento. Estos valores por defecto permiten que ciertos registros se inserten sin necesidad de especificar todos los campos, dejando que la lógica de los disparadores complete la información posteriormente.

7.5. Integridad referencial: llaves foráneas y acciones referenciales

Todas las relaciones entre tablas se implementaron mediante llaves foráneas con acciones referenciales explícitas en **ON DELETE** y **ON UPDATE**. La elección de cada acción se realizó según el significado de la relación dentro del negocio:

- **ON UPDATE CASCADE.** Se utilizó de forma generalizada, de modo que si cambia el identificador de una entidad referenciada, el cambio se propague automáticamente a las tablas que dependen de ella.
- **ON DELETE CASCADE.** Se aplicó a las tablas dependientes cuya existencia no tiene sentido sin la entidad principal. Por ejemplo, los teléfonos y correos de un cliente se eliminan junto con el cliente, pues una vez que el cliente no está más, no interesa guardar su información asociada, mismo caso con las especializaciones que se eliminan junto con el personal, y los renglones de **COMPRAR** que se eliminan junto con su ticket.
- **ON DELETE RESTRICT.** Se aplicó a relaciones donde eliminar la entidad principal podría dejar inconsistente información valiosa. Por ejemplo, no se permite eliminar una sucursal mientras tenga personal asignado (pues pueden seguir perteneciendo a la farmacia aunque su sucursal tenga que cerrar), ni eliminar un medicamento mientras forme parte de una compra o de un suministro. Con esto se protege la historia operativa del sistema.
- **ON DELETE SET NULL.** Se aplicó en la relación entre **CONSULTA** y **ENFERMERA**, ya que la participación de la enfermera es opcional. Si se elimina el registro de una enfermera, la consulta se conserva, pero su referencia a la enfermera queda en nulo.

Un caso especial de integridad referencial es la referencia a roles especializados: la tabla **CONSULTA** no apunta directamente a **PERSONAL**, sino a **MEDICO** y **ENFERMERA**; de igual forma, **PREPARAR** y **USAR** apuntan a **FARMACEUTICO**. Esto asegura, a nivel de base de datos, que solo personal con el rol adecuado pueda participar en cada operación.

7.6. Documentación del esquema y orden de carga

Finalmente, el archivo **DDL.sql** incluye instrucciones **COMMENT ON TABLE** y **COMMENT ON COLUMN** que documentan, dentro del propio diccionario de datos de PostgreSQL, el propósito de las tablas y de las columnas más relevantes.

El orden de carga recomendado para reconstruir la base de datos completa es ejecutar primero **DDL.sql** (estructura), después **Trigger.sql** (lógica automática), después **DML.sql** (datos) y, por último, **SP.sql** y **Funciones.sql** (funciones y procedimientos), para finalmente poder ejecutar las consultas de **DQL.sql**. Este orden garantiza que cada componente encuentre disponibles las estructuras de las que depende.

8. Poblamiento de la base de datos

El poblamiento de la base de datos se realizó con el propósito de validar el correcto funcionamiento del modelo relacional desarrollado para el sistema de clínica y farmacia. La información insertada busca representar escenarios reales de operación dentro de la cadena de sucursales médicas, permitiendo comprobar tanto la integridad de los datos como el comportamiento de las consultas, restricciones y relaciones definidas en el esquema.

El objetivo principal del poblamiento fue generar un conjunto de datos suficientemente amplio y variado para:

- Verificar la integridad referencial entre tablas.
- Validar restricciones de dominio, llaves primarias y llaves foráneas.
- Simular operaciones reales de una clínica y farmacia.
- Garantizar que las consultas desarrolladas en el DQL devolvieran resultados representativos.
- Evaluar relaciones entre clientes, personal, medicamentos, consultas y sucursales.

Se consideraron distintos escenarios de uso reales dentro del sistema. Se generaron datos para clientes, sucursales, personal médico, enfermería, farmacéuticos, proveedores, medicamentos, consultas y tickets de compra.

Los registros fueron distribuidos de manera que existieran relaciones válidas entre las entidades principales del modelo. Por ejemplo:

- Cada empleado pertenece a una sucursal.
- Las consultas están asociadas a médicos, enfermeras y clientes existentes.
- Los tickets de compra están relacionados con clientes y sucursales válidas.
- Los medicamentos y los insumos cuentan con proveedores asociados.

Además, se incorporaron datos suficientes para cubrir distintos casos de prueba solicitados en las consultas del proyecto.

Se poblaron múltiples sucursales distribuidas en distintos estados para simular una operación real a gran escala. También se incluyeron diferentes tipos de empleados especializados, como médicos, enfermeras, cajeros, farmacéuticos y personal de limpieza, con el fin de validar las especializaciones del modelo relacional.

En cuanto a los clientes, se consideraron distintos perfiles:

- Clientes físicos.
- Clientes en línea.
- Pacientes que reciben consultas.
- Clientes que únicamente realizan compras.

Esto permitió ejecutar consultas relacionadas con historiales médicos, compras, tickets y comportamiento de usuarios.

El poblamiento también fue diseñado para garantizar resultados válidos en las consultas desarrolladas. Por ejemplo:

- Se insertaron enfermeras con apellidos maternos que contienen la secuencia “llo” para validar búsquedas con operadores como `ILIKE 'llo'`.
- Se agregaron clientes con compras registradas pero sin consultas médicas para comprobar consultas con `NOT EXISTS`.
- Se registraron consultas médicas en fechas y horarios específicos para validar filtros temporales.
- Se añadieron múltiples tickets y compras de medicamentos para realizar cálculos de precios brutos, precios netos e ingresos totales.

- Se incorporaron suficientes médicos y empleados en distintas sucursales para probar agrupaciones y conteos.

Gracias a esto, todas las consultas pudieron ejecutarse correctamente y devolver información coherente con el modelo propuesto.

El poblamiento también permitió comprobar el funcionamiento de las restricciones implementadas en el DDL, incluyendo:

- Restricciones NOT NULL.
- Restricciones CHECK.
- Restricciones UNIQUE.
- Llaves primarias.
- Llaves foráneas.
- Acciones ON DELETE y ON UPDATE.

De esta manera se verificó que los datos almacenados mantienen consistencia y cumplen las reglas del negocio establecidas.

9. Procedimientos, funciones y disparadores

Además de la estructura de tablas y restricciones definida en DDL.sql, la base de datos incorpora una capa de *lógica programada* que se ejecuta dentro del propio manejador. Con ella podemos implementar cosas que no están al alcance de la base de datos y que son de mucho interés para el cliente el hecho de que sean automáticos y obtener resultados interesantes a partir de esto. Conviene distinguir los tres tipos de objetos, ya que cumplen funciones distintas. Una **función** recibe parámetros y regresa un valor; se utiliza dentro de consultas o de otros objetos para obtener un resultado. Un **procedimiento almacenado** agrupa una serie de operaciones que se ejecutan mediante la instrucción **CALL**, y se usa principalmente para automatizar tareas que modifican la base de datos. Un **disparador** es una rutina que se ejecuta de forma automática cuando ocurre un evento dado sobre una tabla, como una inserción, una actualización o una eliminación.

9.1. Funciones (archivo Funciones.sql)

El archivo **Funciones.sql** contiene dos funciones que resuelven necesidades concretas de consulta sobre la información de la farmacia.

La primera función, **reconoceredad**, recibe el identificador de un cliente y regresa su edad en años cumplidos. Internamente busca la fecha de nacimiento del cliente en la tabla **CLIENTE** y, si la encuentra, calcula la diferencia respecto a la fecha actual utilizando las funciones **AGE** y **DATE_PART** de PostgreSQL. Si el cliente no existe o no tiene fecha registrada, la función regresa un valor nulo, lo que permite manejar el caso de forma controlada. Esta función es útil para generar reportes por grupos de edad o para validar condiciones que dependen de la edad del cliente.

La segunda función, **calculaganancias**, recibe el nombre de una sucursal y calcula sus ganancias durante el año 2026. Para ello suma dos componentes: por un lado, la venta de medicamentos, obtenida al multiplicar la cantidad comprada por el precio público en cada renglón de los tickets de la sucursal; y por otro, los ingresos por consultas, obtenidos al sumar el costo de las consultas realizadas en las clínicas de esa sucursal. Ambas sumas se filtran por el año correspondiente y se utiliza la función **COALESCE** para

que el resultado sea cero cuando no existan ventas o consultas, evitando así valores nulos. Esta función ofrece una visión rápida del desempeño económico de cada sucursal y puede aplicarse de forma masiva sobre todas las sucursales en una sola consulta.

9.2. Procedimientos almacenados (archivo SP.sql)

El archivo `SP.sql` contiene dos procedimientos almacenados que automatizan operaciones frecuentes de mantenimiento de la información.

El primero, `sp_registrar_farmaceutico`, registra a un nuevo integrante del personal y, al mismo tiempo, lo da de alta como farmacéutico. Antes de insertar cualquier dato, el procedimiento realiza una serie de validaciones: comprueba que el nombre y los apellidos no estén vacíos y que solo contengan letras y espacios (mediante una expresión regular que admite vocales acentuadas y la letra ñ); verifica que la cédula tenga la longitud esperada, que el RFC tenga 13 caracteres y que el salario no sea negativo; y confirma que la sucursal indicada exista. Si alguna validación falla, el procedimiento detiene la operación con un mensaje de error claro. Una vez superadas las validaciones, calcula el siguiente identificador de personal y, para evitar que dos sesiones obtengan el mismo identificador al mismo tiempo, bloquea brevemente la tabla `PERSONAL`. Finalmente, inserta el registro en `PERSONAL` y enseguida el mismo identificador en `FARMACEUTICO`, respetando el orden de dependencia entre ambas tablas. Este procedimiento es un buen ejemplo de cómo una operación que en realidad afecta a dos tablas se encapsula en una sola llamada segura y validada.

El segundo procedimiento, `sp_eliminar_medicamento`, elimina un medicamento a partir de su identificador. Dado que el esquema utiliza llaves foráneas con restricciones, no es posible eliminar directamente un medicamento que aún tiene registros relacionados. Por ello, el procedimiento primero verifica que el medicamento exista y después elimina, en orden, las filas que lo referencian en las tablas `PROVEER_MEDICAMENTO`, `PREPARAR`, `UTILIZAR`, `COMPRAR` y `PEDIR`, y solo al final elimina el registro principal de `MEDICAMENTO`. Durante el proceso utiliza la instrucción `GET DIAGNOSTICS` para informar cuántas filas se eliminaron en cada tabla relacionada, lo que da trazabilidad a la operación. De esta manera, una eliminación que podría ser compleja y propensa a errores se realiza de forma ordenada y segura.

9.3. Archivo de triggers

El archivo `Trigger.sql` contiene la definición de los disparadores utilizados para automatizar ciertas operaciones dentro de la base de datos. En este proyecto, estos disparadores se utilizan principalmente para mantener la consistencia de la información relacionada con el inventario de medicamentos y con el cálculo de los importes de los tickets de compra.

Este archivo forma parte del conjunto de scripts SQL del proyecto y no funciona de manera aislada. Para que los triggers puedan ejecutarse correctamente, primero deben existir las tablas, columnas, llaves primarias y llaves foráneas sobre las que trabajan. Por esta razón, el archivo `Trigger.sql` depende directamente del archivo `DDL.sql`, ya que en este último se define la estructura de la base de datos. En particular, los triggers utilizan tablas como `MEDICAMENTO`, `PROVEER_MEDICAMENTO`, `PREPARAR`, `COMPRAR` y `TICKET`, además de columnas como `Stock`, `Cantidad`, `PrecioPublico`, `PrecioBruto`, `DescuentoAplicado` y `PrecioNeto`.

En términos generales, el archivo `Trigger.sql` cubre dos procesos principales. El primero es la actualización automática del stock de medicamentos cuando se registran entradas o salidas de inventario. El segundo es el cálculo automático de los valores económicos del ticket, incluyendo el precio bruto, el descuento aplicado y el precio neto. Estos procesos son relevantes porque corresponden a operaciones frecuentes dentro del sistema y porque afectan directamente la exactitud de la información almacenada.

9.4. Importancia de los triggers

El uso de triggers permite reducir la cantidad de tareas manuales que tendrían que realizarse desde una aplicación externa o directamente por el usuario. Por ejemplo, si cada vez que se compra un medicamento se tuviera que actualizar manualmente el campo **Stock** en la tabla **MEDICAMENTO**, existiría un mayor riesgo de errores. Podría olvidarse el descuento, duplicarse una operación o modificarse un valor incorrecto. Al utilizar triggers, esta lógica queda integrada dentro de la propia base de datos.

Esto también ayuda a mantener una mayor consistencia en la información. La consistencia es importante porque los datos de distintas tablas están relacionados entre sí. Una compra registrada en la tabla **COMPRAR** debe verse reflejada en el inventario de **MEDICAMENTO**. De la misma forma, los productos asociados a un ticket deben afectar el total almacenado en la tabla **TICKET**. Si estas operaciones no estuvieran automatizadas, sería posible que el sistema mostrara una compra realizada, pero que el inventario no se hubiera reducido, o que un ticket tuviera productos asociados pero un total incorrecto.

9.5. Control del stock de medicamentos

Una de las funciones principales del archivo **Trigger.sql** es mantener actualizado el inventario de medicamentos. Este inventario se representa mediante la columna **Stock** de la tabla **MEDICAMENTO**. Dicha columna indica cuántas unidades disponibles existen de cada medicamento registrado en el sistema.

El control del stock se realiza a partir de tres tablas relacionadas con movimientos de medicamentos: **PROVEER_MEDICAMENTO**, **PREPARAR** y **COMPRAR**. Cada una de estas tablas representa un tipo distinto de operación. La tabla **PROVEER_MEDICAMENTO** representa la entrada de medicamentos por parte de proveedores. La tabla **PREPARAR** representa la preparación de medicamentos por parte del personal farmacéutico. La tabla **COMPRAR** representa la salida de medicamentos cuando un cliente realiza una compra.

El trigger asociado a **PROVEER_MEDICAMENTO** se encarga de aumentar el inventario cuando un proveedor entrega medicamentos. Cuando se inserta un nuevo registro en esta tabla, la cantidad recibida se suma automáticamente al **Stock** del medicamento correspondiente. Esto permite que el inventario refleje las nuevas existencias sin necesidad de hacer una actualización manual adicional en la tabla **MEDICAMENTO**.

Además, este trigger también contempla los casos en los que un registro de proveedor se modifica o se elimina. Cuando se actualiza una entrega de medicamento, el sistema no simplemente suma la nueva cantidad, porque eso produciría un resultado incorrecto. Primero debe revertir el efecto del valor anterior y después aplicar el nuevo valor. Por ejemplo, si originalmente se registraron 20 unidades y después se corrige el registro a 30 unidades, el sistema debe quitar primero las 20 unidades anteriores y luego sumar las 30 nuevas. De esta manera, el resultado final del inventario será correcto.

En caso de eliminación, el trigger descuenta del inventario la cantidad que había sido registrada como entrada. Esto tiene sentido porque, si se elimina el registro de una entrega, esa entrada ya no debe formar parte del cálculo de existencias. Sin este comportamiento, el stock podría quedar inflado artificialmente, ya que seguiría considerando medicamentos que en realidad ya no están respaldados por un registro válido.

La tabla **PREPARAR** funciona de manera similar, pero representa un origen diferente de medicamento. En este caso, el medicamento no llega directamente de un proveedor, sino que es preparado por personal farmacéutico. Cuando se registra una preparación, el trigger suma la cantidad preparada al **Stock** del medicamento correspondiente. Esto permite representar que, después de la preparación, existen más unidades disponibles para su uso o venta.

También se manejan actualizaciones y eliminaciones sobre **PREPARAR**. Si se cambia la cantidad preparada o el medicamento asociado, el sistema ajusta el inventario quitando primero el efecto del registro anterior y aplicando después el nuevo. Si se elimina la preparación, se descuenta la cantidad que había

sido agregada al stock. Este comportamiento mantiene la coherencia entre la tabla de preparaciones y la tabla principal de medicamentos.

La tabla **COMPRAR** representa el caso contrario a las entradas de inventario, ya que registra medicamentos vendidos o comprados por clientes. Por eso, el trigger asociado a esta tabla disminuye el **Stock** cuando se inserta una nueva compra. Antes de realizar el descuento, el sistema verifica que exista suficiente inventario disponible. Si la cantidad solicitada es menor o igual al stock actual, la operación se permite y el stock se actualiza. Si no hay suficiente inventario, el trigger genera un error y evita que la compra se registre.

Esta validación es especialmente importante porque impide que el inventario quede en valores negativos. Un stock negativo indicaría que el sistema permitió vender más unidades de las que realmente existían, lo cual representaría una inconsistencia grave. Al bloquear la operación cuando no hay existencias suficientes, el trigger ayuda a proteger la integridad de la información.

El trigger de **COMPRAR** también considera el caso de actualizaciones. Si una compra ya registrada se modifica, el sistema debe manejar el cambio cuidadosamente. Primero devuelve al inventario la cantidad anterior, como si la compra original se deshiciera. Después verifica si existe stock suficiente para aplicar la nueva cantidad. Si la validación se cumple, descuenta la cantidad actualizada. Este proceso es necesario porque una actualización puede cambiar no solo la cantidad, sino también el medicamento o el ticket asociado.

Por ejemplo, si originalmente se compraron 2 unidades de un medicamento y después se cambia a 5 unidades, no basta con restar 5 directamente, ya que las 2 unidades originales ya habían sido descontadas. Lo correcto es devolver primero las 2 unidades y luego intentar descontar 5. Esto evita errores acumulados en el inventario.

Cuando se elimina una compra, el trigger devuelve al inventario la cantidad que había sido descontada. Esto significa que, si la venta deja de existir dentro del sistema, las unidades correspondientes vuelven a estar disponibles. Este comportamiento es coherente con la idea de que el stock debe reflejar únicamente las compras actualmente registradas.

9.6. Cálculo de descuentos

Además del control de inventario, el archivo **Trigger.sql** tiene lógica para calcular descuentos asociados a los tickets. Esta parte se relaciona con la tabla **TICKET** y con la función **fn_calcular_descuento**. El objetivo de esta función es determinar qué porcentaje de descuento debe aplicarse a un ticket dependiendo de la cantidad de tickets registrados previamente durante ese mismo año.

La regla de descuento se basa en rangos. Si existen de 0 a 99 tickets previos en el año, el descuento aplicado es de 0 por ciento. Si existen de 100 a 499 tickets, el descuento es de 5 por ciento. Si existen de 500 a 1999 tickets, el descuento es de 10 por ciento. Entonces, si existen 2000 o más tickets previos, el descuento es de 15 por ciento.

Esta lógica permite que el sistema aplique descuentos de manera automática conforme aumenta la cantidad de operaciones registradas. El descuento no se calcula manualmente al momento de crear cada ticket, sino que se obtiene mediante una función que evalúa la cantidad de tickets existentes. Esto evita que el usuario tenga que recordar qué porcentaje corresponde a cada rango y reduce la posibilidad de asignar un descuento incorrecto.

El trigger encargado de aplicar este cálculo se ejecuta antes de insertar un nuevo registro en la tabla **TICKET**. Al ser un trigger de tipo **BEFORE INSERT**, puede modificar los valores del nuevo registro antes de que este quede guardado definitivamente. Este comportamiento es útil porque permite que el ticket sea insertado ya con su descuento inicial y con sus importes preparados.

Durante este proceso, el trigger revisa primero la fecha del ticket. Si la columna **Fecha** no tiene un valor definido, se asigna automáticamente la fecha actual mediante **CURRENT_DATE**. Después, con base en esa fecha, se cuentan los tickets existentes en el mismo año. A partir de ese número, se llama a la

función `fn_calcular_descuento` para obtener el porcentaje correspondiente y guardarlo en la columna `DescuentoAplicado`.

Además de calcular el descuento, este trigger inicializa los campos económicos del ticket. Si `PrecioBruto` o `PrecioNeto` no tienen valores definidos, se asigna un valor inicial de cero. Esto es importante porque, al momento de crear un ticket, puede que todavía no existan medicamentos asociados a él. En ese caso, el ticket puede iniciar con total cero y actualizarse posteriormente cuando se agreguen productos en la tabla `COMPRAR`.

9.7. Cálculo del precio bruto y precio neto

El archivo `Trigger.sql` también se encarga de mantener actualizados los importes del ticket. En particular, trabaja con los campos `PrecioBruto` y `PrecioNeto` de la tabla `TICKET`. El `PrecioBruto` representa el total antes de aplicar descuentos, mientras que el `PrecioNeto` representa el total final después de aplicar el porcentaje almacenado en `DescuentoAplicado`.

El cálculo del `PrecioBruto` se obtiene a partir de los medicamentos asociados al ticket en la tabla `COMPRAR`. Para cada medicamento comprado, se multiplica la cantidad registrada por el precio público del medicamento, almacenado en la columna `PrecioPublico` de la tabla `MEDICAMENTO`. Después, se suman todos esos resultados para obtener el total bruto del ticket.

Por ejemplo, si un ticket incluye dos medicamentos distintos, el sistema calcula el subtotal de cada uno multiplicando la cantidad por el precio correspondiente. Después suma ambos subtotales y guarda el resultado en `PrecioBruto`. Posteriormente, aplica el porcentaje de descuento guardado en `DescuentoAplicado` para obtener el `PrecioNeto`.

Este cálculo se actualiza automáticamente cuando ocurre un cambio en la tabla `COMPRAR`. Si se inserta una nueva compra asociada a un ticket, el total aumenta. Si se modifica una compra, el total se recalcula con los nuevos valores. Si se elimina una compra, el total disminuye. De esta forma, el ticket no depende de cálculos manuales ni de valores escritos directamente por el usuario.

Una ventaja de este enfoque es que el ticket siempre refleja el estado actual de sus productos asociados. Si cambia la cantidad de medicamentos comprados, el total se ajusta. Si se quita un medicamento del ticket, el total también se actualiza. Esto evita diferencias entre el detalle de la compra y los totales almacenados en la tabla `TICKET`.

El trigger también contempla el caso en el que una actualización mueva una compra de un ticket a otro. Esto puede ocurrir si se cambia el identificador del ticket en un registro de la tabla `COMPRAR`. En ese escenario, no basta con recalcular el ticket nuevo, porque el ticket anterior también queda afectado. Por eso, la lógica considera ambos casos y recalcula tanto el ticket que recibe la compra como el ticket del que se retiró.

Este comportamiento es importante porque evita que un ticket conserve un importe correspondiente a productos que ya no le pertenecen. También evita que el nuevo ticket quede sin considerar una compra que ahora sí forma parte de él. En otras palabras, el trigger mantiene sincronizada la relación entre el detalle de compra y los totales del ticket.

9.8. Eventos que detectan los triggers

Los triggers del archivo `Trigger.sql` consideran principalmente tres tipos de eventos: `INSERT`, `UPDATE` y `DELETE`. Cada uno de estos eventos tiene un efecto diferente sobre la información almacenada.

El evento `INSERT` ocurre cuando se agrega un nuevo registro. En el caso de `PROVEER_MEDICAMENTO` y `PREPARAR`, una inserción representa una entrada de inventario, por lo que el stock aumenta. En el caso de `COMPRAR`, una inserción representa una salida de inventario, por lo que el stock disminuye. En el caso

de **TICKET**, una inserción representa la creación de un nuevo ticket, por lo que se calculan sus valores iniciales.

El evento **UPDATE** ocurre cuando se modifica un registro existente. Este evento requiere más cuidado porque el sistema debe considerar tanto el valor anterior como el nuevo valor. Por eso se utilizan referencias a los datos previos y actuales del registro. La idea general es deshacer primero el efecto del registro anterior y aplicar después el efecto del registro actualizado.

El evento **DELETE** ocurre cuando se elimina un registro. En este caso, el sistema debe revertir el efecto que ese registro tenía sobre otras tablas. Si se elimina una entrada de proveedor, se descuenta del inventario la cantidad que había sido agregada. Si se elimina una preparación, también se descuenta la cantidad correspondiente. Si se elimina una compra, se devuelve al inventario la cantidad que había sido vendida y se recalcula el total del ticket.

Considerar estos tres eventos hace que la lógica sea más completa. No solo se automatiza lo que sucede cuando se insertan datos nuevos, sino también lo que ocurre cuando esos datos se corrigen o se eliminan. Esto es importante porque, en un sistema real, los registros pueden modificarse por errores de captura, cancelaciones, ajustes administrativos o cambios en la operación.

9.9. Relación con la integridad de los datos

El archivo **Trigger.sql** contribuye a la integridad de los datos porque ayuda a que la información relacionada entre distintas tablas se mantenga coherente. La integridad no depende únicamente de llaves primarias y llaves foráneas. Aunque estas restricciones son importantes para asegurar que los registros se relacionen correctamente, no siempre son suficientes para mantener actualizados los valores derivados, como el stock o los totales de un ticket.

Por ejemplo, una llave foránea puede asegurar que una compra haga referencia a un medicamento existente, pero no impide por sí sola que se vendan más unidades de las disponibles. Para controlar ese tipo de regla se necesita una validación adicional, como la implementada en el trigger de **COMPRAR**. De manera similar, una llave foránea puede asegurar que una compra pertenezca a un ticket válido, pero no recalcula automáticamente el total de ese ticket. Para eso se requiere la lógica adicional definida en los triggers.

En este sentido, los triggers funcionan como una capa complementaria de control. Las restricciones estructurales garantizan que las relaciones básicas sean válidas, mientras que los triggers permiten aplicar reglas más específicas del negocio. Esta combinación ayuda a que la base de datos sea más robusta y menos propensa a inconsistencias.

9.10. Alcance del archivo

El archivo **Trigger.sql** cubre una parte importante de la lógica automática del sistema, especialmente en lo relacionado con medicamentos y tickets. Su alcance principal puede resumirse en dos áreas: el mantenimiento automático del inventario de medicamentos y el cálculo automático de los importes económicos del ticket.

En cuanto al inventario, el archivo permite registrar entradas de medicamentos por proveedor, entradas por preparación y salidas por compra. También considera modificaciones y eliminaciones, lo que hace que la lógica sea más completa que si solo se trabajara con inserciones. Además, incluye una validación para evitar que una compra deje el inventario en negativo.

En cuanto a los tickets, el archivo permite asignar descuentos automáticos según la cantidad de tickets previos en el año y recalcular los importes cuando cambian los medicamentos asociados a un ticket. Esto facilita que los campos **PrecioBruto**, **DescuentoAplicado** y **PrecioNeto** se mantengan actualizados sin intervención manual.

Query

Query History

```
343
344 -- Consulta xv
345 -- Sucursales que cuentan con clínica médica integrada,
346 -- mostrando el nombre de la clínica, número de cuartos
347 -- y los horarios de atención (agrupados).
348
349 SELECT
350
351     S.IDSucursal,
352     S.Nombre           AS NombreSucursal,
353     S.Estado,
354     CL.IDClinica,
355     CL.Nombre          AS NombreClinica,
356     CL.NumCuartos,
357     STRING_AGG(DISTINCT HC.Horario, ';' ORDER BY HC.Horario) AS HorariosClinica
358 FROM SUCURSAL AS S
359 INNER JOIN CLINICA AS CL
360     ON S.IDSucursal = CL.IDSucursal
361 LEFT JOIN HORARIO_CLINICA AS HC
362     ON CL.IDClinica = HC.IDClinica
363 GROUP BY
```

Data Output

Messages

Notifications

SQL

	idsucursal integer	nombrsucursal character varying (120)	estado character varying (80)	idclinica integer	nombreclinica character varying (150)	numcuartos integer	horariosclinica text
1	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	Baja California Sur	1	Shakshaft	12	Lun-Dom 08:00-2...
2	2	Sucursal Los SuperDatos 0...	Chiapas	2	Garretson	12	Lun-Sab 07:00-19...
3	3	Sucursal Los SuperDatos 0...	Hidalgo	3	Laybourne	16	Lun-Dom 08:00-2...
4	4	Sucursal Los SuperDatos 0...	Hidalgo	4	Mosey	3	Lun-Sab 07:00-19...
5	5	Sucursal Los SuperDatos 0...	Coahuila	5	Bonnaire	9	Lun-Dom 08:00-2...
6	6	Sucursal Los SuperDatos 0...	Yucat��n	6	Siderfin	9	Lun-Sab 07:00-19...
7	7	Sucursal Los SuperDatos 0...	Chiapas	7	Dixsee	5	Lun-Sab 07:00-19...
8	8	Sucursal Los SuperDatos 0...	Tlaxcala	8	Conerding	18	Lun-Dom 08:00-2...
9	9	Sucursal Los SuperDatos 0...	Tlaxcala	9	Crutchley	19	Lun-Dom 08:00-2...
10	10	Sucursal Los SuperDatos 0...	Coahuila	10	Roughley	11	Lun-Dom 08:00-2...
11	11	Sucursal Los SuperDatos 0...	Puebla	11	Richold	15	Lun-Sab 07:00-19...
12	12	Sucursal Los SuperDatos 0...	Yucat��n	12	Brine	20	Lun-Dom 08:00-2...
13	13	Sucursal Los SuperDatos 0...	Ciudad de M��xico	13	Attie	2	24 horas

10.3. Consulta xvi — Cantidad de empleados por sucursal

- Las sucursales con más empleados probablemente tienen mayor flujo de clientes o mayores operaciones.
- Una sucursal con muy poco personal podría enfrentar saturación o tiempos largos de atención.
- Permite detectar cuáles sucursales requieren expansión de personal.

Query

Query History

371

--

372

-- Consulta xvi

373

-- Número total de empleados por sucursal y por tipo de puesto.

374

-- Se realiza una pivot manual sobre las especializaciones

375

-- (médico, enfermera, farmacéutico, cajero, limpieza, cuidador).

376

377

SELECT

378

S.IDSucursal,

379

S.Nombre AS NombreSucursal,

380

COUNT(DISTINCT P.IDPersonal) AS TotalEmpleados,

381

COUNT(DISTINCT ME.IDPersonal) AS TotalMedicos,

382

COUNT(DISTINCT EN.IDPersonal) AS TotalEnfermeras,

383

COUNT(DISTINCT FA.IDPersonal) AS TotalFarmaceuticos,

384

COUNT(DISTINCT CA.IDPersonal) AS TotalCajeros,

385

COUNT(DISTINCT LI.IDPersonal) AS TotalLimpieza,

386

COUNT(DISTINCT CU.IDPersonal) AS TotalCuidadores

387

FROM SUCURSAL AS S

388

LEFT JOIN PERSONAL AS P ON S.IDSucursal = P.IDSucursal

389

LEFT JOIN MEDICO AS ME ON P.IDPersonal = ME.IDPersonal

390

LEFT JOIN ENFERMERA AS EN ON P.IDPersonal = EN.IDPersonal

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 1000

	idsucursal	nombrsucursal	totalempleados	totalmedicos	totalenfermeras	totalfarmaceuticos	totalcajeros	totallimpieza	totalcuidadores
	[PK] integer	character varying (120)	bigint	bigint	bigint	bigint	bigint	bigint	bigint
1	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	15	6	1	2	1	2	1
2	4	Sucursal Los SuperDatos 0...	14	5	1	2	1	3	1
3	6	Sucursal Los SuperDatos 0...	12	7	2	0	1	2	0
4	30001	Sucursal Manual 001	12	2	2	2	2	2	2
5	30002	Sucursal Manual 002	12	2	2	2	2	2	2
6	30003	Sucursal Manual 003	12	2	2	2	2	2	2
7	30004	Sucursal Manual 004	12	2	2	2	2	2	2
8	30005	Sucursal Manual 005	12	2	2	2	2	2	2
9	30006	Sucursal Manual 006	12	2	2	2	2	2	2
10	30007	Sucursal Manual 007	12	2	2	2	2	2	2
11	30008	Sucursal Manual 008	12	2	2	2	2	2	2
12	30009	Sucursal Manual 009	12	2	2	2	2	2	2
13	30010	Sucursal Manual 010	12	2	2	2	2	2	2

10.4. Consulta xvii — Salarios promedio por categoría de empleado

- Los puestos con mayores salarios reflejan áreas de especialización o mayor responsabilidad.
- Diferencias salariales muy marcadas pueden evidenciar jerarquías operativas importantes.
- Permite evaluar si existe equilibrio entre funciones médicas, administrativas y operativas.

Query

Query History

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

-- Consulta xvii

-- Salario promedio del personal por sucursal y por categoría

-- de puesto, incluyendo salario mínimo y máximo por grupo.

WITH PersonalCategorizado AS (

SELECT

P.IDPersonal,

P.IDSucursal,

P.Salario,

CASE

WHEN ME.IDPersonal IS NOT NULL THEN 'Medico'

WHEN EN.IDPersonal IS NOT NULL THEN 'Enfermera'

WHEN FA.IDPersonal IS NOT NULL THEN 'Farmaceutico'

WHEN CA.IDPersonal IS NOT NULL THEN 'Cajero'

WHEN LI.IDPersonal IS NOT NULL THEN 'Limpieza'

WHEN CU.IDPersonal IS NOT NULL THEN 'Cuidador'

ELSE 'Sin categoria'

END AS Categoria

FROM PERSONAL AS P

Data Output

Messages

Notifications

SQL

	IdSucursal [PK] integer	nombresucursal character varying (120)	categoria text	totalpersonas bigint	salariopromedio numeric	salariominimo numeric	salariomaximo numeric
1	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	Cajero	1	10063.86	10063.86	10063.86
2	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	Cuidador	1	30950.20	30950.20	30950.20
3	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	Enfermera	1	18100.00	18100.00	18100.00
4	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	Farmaceuti...	2	27844.25	26546.84	29141.65
5	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	Limpieza	2	23080.42	19579.38	26581.45
6	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	Medico	6	32621.23	32150.00	33477.35
7	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	Sin catego...	2	22343.10	16675.57	28010.62
8	2	Sucursal Los SuperDatos 0...	Cuidador	3	25744.69	21381.22	32878.21
9	2	Sucursal Los SuperDatos 0...	Enfermera	1	18200.00	18200.00	18200.00
10	2	Sucursal Los SuperDatos 0...	Farmaceuti...	1	26984.18	26984.18	26984.18
11	2	Sucursal Los SuperDatos 0...	Medico	5	33200.00	32900.00	33500.00
12	3	Sucursal Los SuperDatos 0...	Enfermera	2	13125.81	7951.61	18300.00
13	3	Sucursal Los SuperDatos 0...	Medico	5	33950.00	33650.00	34250.00

10.5. Consulta xviii — Farmacéuticos y preparación de medicamentos especiales

- Los farmacéuticos con mayor número de preparaciones pueden considerarse personal altamente especializado.
- Una alta frecuencia de medicamentos especiales indica demanda médica compleja.
- Permite identificar áreas donde se requiere capacitación técnica adicional.

Query	Query History
447	
448	
449	-- Consulta xviii
450	-- Fármacos que preparan medicamentos especiales,
451	-- detallando cuántos preparan de cada tipo: estériles,
452	-- pediátricos, dermatológicos y preparados oficiales.
453	
454	SELECT
455	P.IDPersonal,
456	CONCAT(P.Nombre, ' ', P.ApellidoPaterno, ' ', P.ApellidoMaterno) AS NombreFarmaceutico,
457	P.IDSocursal,
458	COUNT(DISTINCT CASE WHEN M.MedicamentosEstériles THEN M.IDMedicamento END) AS EsterilesPreparados,
459	COUNT(DISTINCT CASE WHEN M.Pediatrica THEN M.IDMedicamento END) AS PediatricosPreparados,
460	COUNT(DISTINCT CASE WHEN M.Dermatologica THEN M.IDMedicamento END) AS DermatologicosPreparados,
461	COUNT(DISTINCT CASE WHEN M.PreparadosOficiales THEN M.IDMedicamento END) AS PreparadosOficiales,
462	COUNT(DISTINCT M.IDMedicamento) AS TotalMedicamentosPreparados
463	FROM FARMACEUTICO AS F
464	INNER JOIN PERSONAL AS P ON F.IDPersonal = P.IDPersonal
465	INNER JOIN PREPARAR AS PR ON F.IDPersonal = PR.IDPersonal
466	INNER JOIN MEDICAMENTO AS M ON PR.IDMedicamento = M.IDMedicamento
467	ORDER BY
468	
469	
470	
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	
479	
480	
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
490	
491	
492	
493	
494	
495	
496	
497	
498	
499	
500	
501	
502	
503	
504	
505	
506	
507	
508	
509	
510	
511	
512	
513	
514	
515	
516	
517	
518	
519	
520	
521	
522	
523	
524	
525	
526	
527	
528	
529	
530	
531	
532	
533	
534	
535	
536	
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	
544	
545	
546	
547	
548	
549	
550	
551	
552	
553	
554	
555	
556	
557	
558	
559	
560	
561	
562	
563	
564	
565	
566	
567	
568	
569	
570	
571	
572	
573	
574	
575	
576	
577	
578	
579	
580	
581	
582	
583	
584	
585	
586	
587	
588	
589	
590	
591	
592	
593	
594	
595	
596	
597	
598	
599	
600	
601	
602	
603	
604	
605	
606	
607	
608	
609	
610	
611	
612	
613	
614	
615	
616	
617	
618	
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	
626	
627	
628	
629	
630	
631	
632	
633	
634	
635	
636	
637	
638	
639	
640	
641	
642	
643	
644	
645	
646	
647	
648	
649	
650	
651	
652	
653	
654	
655	
656	
657	
658	
659	
660	
661	
662	
663	
664	
665	
666	
667	
668	
669	
670	
671	
672	
673	
674	
675	
676	
677	
678	
679	
680	
681	
682	
683	
684	
685	
686	
687	
688	
689	
690	
691	
692	
693	
694	
695	
696	
697	
698	
699	
700	
701	
702	
703	
704	
705	
706	
707	
708	
709	
710	
711	
712	
713	
714	
715	
716	
717	
718	
719	
720	
721	
722	
723	
724	
725	
726	
727	
728	
729	
730	
731	
732	
733	
734	
735	
736	
737	
738	
739	
740	
741	
742	
743	
744	
745	
746	
747	
748	
749	
750	
751	
752	
753	
754	
755	
756	
757	
758	
759	
760	
761	
762	
763	
764	
765	
766	
767	
768	
769	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
776	
777	
778	
779	
780	
781	
782	
783	
784	
785	
786	
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	
795	
796	
797	
798	
799	
800	
801	
802	
803	
804	
805	
806	
807	
808	
809	
810	
811	
812	
813	
814	
815	
816	
817	
818	
819	
820	
821	
822	
823	
824	
825	
826	
827	
828	
829	
830	
831	
832	
833	
834	
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	
842	
843	
844	
845	
846	
847	
848	
849	
850	
851	
852	
853	
854	
855	
856	
857	
858	
859	
860	
861	
862	
863	
864	
865	
866	
867	
868	
869	
870	
871	
872	
873	
874	
875	
876	
877	
878	
879	
880	
881	
882	
883	
884	
885	
886	
887	
888	
889	
890	
891	
892	
893	
894	
895	
896	
897	
898	
899	
900	
901	
902	
903	
904	
905	
906	
907	
908	
909	
910	
911	
912	
913	
914	
915	
916	
917	
918	
919	
920	
921	
922	
923	
924	
925	
926	
927	
928	
929	
930	
931	
932	
933	
934	
935	
936	
937	
938	
939	
940	
941	
942	
943	
944	
945	
946	
947	
948	
949	
950	
951	
952	
953	
954	
955	
956	
957	
958	
959	
960	
961	
962	
963	
964	
965	
966	
967	
968	
969	
970	
971	
972	
973	
974	
975	
976	
977	
978	
979	
980	
981	
982	
983	
984	
985	
986	
987	
988	
989	
990	
991	
992	
993	
994	
995	
996	
997	
998	
999	
1000	

10.6. Consulta xix — Métodos de pago utilizados por clientes

- El método de pago más utilizado permite entender hábitos de consumo de los clientes.
- El predominio del efectivo podría indicar dependencia de clientes tradicionales.
- Ayuda a definir estrategias de promociones y plataformas de pago.

Query	Query History
478	ORDER BY TotalMedicamentosPreparados DESC;
479	
480	
481	-- Consulta xix
482	-- Distribución de clientes registrados según el método de pago
483	-- que utilizan, separando además a clientes en línea, físicos
484	-- y pacientes.
485	
486	SELECT
487	COALESCE(C.MetodoPago, 'Sin metodo registrado') AS MetodoPago,
488	COUNT(*) AS TotalClientes,
489	ROUND(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*) OVER (), 2) AS PorcentajeDelTotal,
490	SUM(CASE WHEN C.EsClienteEnLinea THEN 1 ELSE 0 END) AS ClientesEnLinea,
491	SUM(CASE WHEN C.EsClienteFisico THEN 1 ELSE 0 END) AS ClientesFisicos,
492	SUM(CASE WHEN C.EsPaciente THEN 1 ELSE 0 END) AS ClientesPacientes
493	FROM CLIENTE AS C
494	GROUP BY C.MetodoPago
495	ORDER BY TotalClientes DESC;
496	
497	
498	
499	
500	
501	
502	
503	
504	
505	
506	
507	
508	
509	
510	
511	
512	
513	
514	
515	
516	
517	
518	
519	
520	
521	
522	
523	
524	
525	
526	
527	
528	
529	
530	
531	
532	
533	
534	
535	
536	
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	
544	
545	
546	
547	
548	
549	
550	
551	
552	
553	
554	
555	
556	
557	
558	
559	
560	
561	
562	
563	
564	
565	
566	

10.7. Consulta xx — Tickets con descuentos o promociones

- Un alto número de descuentos puede indicar estrategias agresivas de fidelización.
- Clientes frecuentes con promociones recurrentes podrían representar consumidores leales.
- Si demasiadas ventas dependen de descuentos, podría existir riesgo de reducción de ganancias.
- Permite evaluar el impacto comercial de campañas promocionales.

Query History

```

498 -- Consulta xx
499 -- Clientes con descuentos aplicados durante el año en curso.
500 -- El descuento no se recalcula aquí: se lee desde TICKET.DescuentoAplicado,
501 -- que es asignado por el trigger trg_ticket_set_descuento al insertar
502 -- cada ticket y se usa después para calcular TICKET.PrecioNeto.
503
504 WITH TicketsConDescuento AS (
505     SELECT
506         T.IDTicket,
507         T.IDCliente,
508         T.Fecha,
509         T.PrecioBruto,
510         T.DescuentoAplicado,
511         T.PrecioNeto
512     FROM TICKET AS T
513     WHERE EXTRACT(YEAR FROM T.Fecha) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)
514           AND T.DescuentoAplicado > 0
515 )
516 SELECT
517     C.IDCliente,
518     CONCAT(C.Nombre, ' ', C.ApellidoPaterno, ' ', C.ApellidoMaterno) AS NombreCompleto
519 
```

Data Output

Showing rows: 1 to 456 Page No: 1

	idcliente [PK] integer	nombrecompleto text	ticketacondescuento bigint	descuentominimoaplicado numeric	descuentomaximoaplicado numeric	totalbrutocondescuento numeric	totaldescuento numeric	totalnetocondescuento numeric
1	250	Theodrick Romushkin Goodere	1	5.00	5.00	3903.65	195.18	3708.47
2	135	Rivkah Mievile Duxbary	1	5.00	5.00	3770.85	188.54	3582.31
3	235	Stacy Dakin Spadoni	1	5.00	5.00	3671.15	183.56	3487.59
4	185	Elizabeth Goulder Dorbin	1	5.00	5.00	3430.00	171.50	3258.50
5	125	Tanny Santori Toy	1	5.00	5.00	3301.80	165.09	3136.71
6	200	Tandi Lucarne Presley	1	5.00	5.00	3282.65	164.13	3118.52
7	285	Noellyn Wylie Darnborough	1	5.00	5.00	3209.60	163.48	3106.12
8	144	Ber Loughvee Beedie	1	5.00	5.00	3159.60	157.98	3001.62
9	254	Jaimie Groves Kilgallon	1	5.00	5.00	3125.20	156.26	2968.94
10	224	Reamonn Cobbed Pargent	1	5.00	5.00	3094.20	154.71	2939.49
11	180	Jillie Berdale Bakeup	1	5.00	5.00	3086.40	154.32	2932.08
12	274	Farechka Joannic Semechik	1	5.00	5.00	2989.60	149.48	2840.12
13	199	Lucienne Medier Filiev	1	5.00	5.00			

Successfully run. Total query runtime: 125 msec

10.8. Consulta xxi — Número de consultas médicas realizadas

- Las sucursales con más consultas tienen mayor demanda de atención médica.
- Un incremento constante de consultas puede indicar confianza de los pacientes.
- Permite identificar horarios o temporadas de mayor carga médica.

postgres/postgres@PostgreSQL 18

Query History

```

537
538 -- Consulta xxi
539 -- Número de consultas médicas realizadas por mes,
540 -- mostrando además clientes distintos atendidos,
541 -- médicos activos, costo promedio e ingresos totales
542 -- por mes.
543
544 SELECT
545     EXTRACT(YEAR FROM CON.Fecha) AS Año,
546     EXTRACT(MONTH FROM CON.Fecha) AS Mes,
547     TO_CHAR(CON.Fecha, 'YYYY-MM') AS PeríodoYM,
548     COUNT(*) AS TotalConsultas,
549     COUNT(DISTINCT CON.IDCliente) AS ClientesDistintos,
550     COUNT(DISTINCT CON.IDMedico) AS MedicosActivos,
551     ROUND(AVG(CON.CostoConsulta), 2) AS CostoPromedio,
552     COALESCE(SUM(CON.CostoConsulta), 0) AS IngresosTotalesPorConsultas
553 FROM CONSULTA AS CON
554 GROUP BY
555     EXTRACT(YEAR FROM CON.Fecha),
556     EXTRACT(MONTH FROM CON.Fecha),
557     TO_CHAR(CON.Fecha, 'YYYY-MM')

```

Data Output Messages Notifications

	año numeric	mes numeric	periodoym text	totalconsultas bigint	clientesdistintos bigint	medicosactivos bigint	costopromedio numeric	ingresostotalesporconsultas numeric
1	2026	11	2026-11	10	10	10	865.50	8655.00
2	2026	10	2026-10	31	31	31	592.13	18356.00
3	2026	9	2026-09	42	42	42	696.21	29241.00
4	2026	8	2026-08	62	62	61	765.71	47474.00
5	2026	7	2026-07	62	62	61	597.68	37056.00
6	2026	6	2026-06	60	60	60	758.50	45510.00
7	2026	5	2026-05	69	59	69	491.73	33929.20
8	2026	4	2026-04	30	30	30	399.80	11994.00
9	2026	3	2026-03	31	31	31	436.40	13528.40
10	2026	2	2026-02	28	28	28	471.80	13210.40
11	2026	1	2026-01	31	31	31	507.20	15723.20
12	2025	12	2025-12	31	31	31	544.40	16876.40
13	2025	11	2025-11	30	30	30	581.00	17430.00

10.9. Consulta xxii — Médicos activos y productividad

- Comparar médicos activos con consultas realizadas ayuda a medir productividad médica.
- Un bajo número de consultas por médico podría señalar poca demanda o sobrecontratación.
- Ayuda a planear mejor la distribución de médicos entre sucursales.

Query

Query History

```
563 -- Consulta xxii
564 -- Top 51 medicamentos más recetados en todo el sistema,
565 -- con el número de recetas distintas en las que aparecen
566 -- y un resumen de las dosis prescritas.
567
568 SELECT
569     M.IDMedicamento,
570     COUNT(PE.NumeroReceta)                AS VecesRecetado,
571     COUNT(DISTINCT PE.NumeroReceta)       AS RecetasDistintas,
572     STRING_AGG(DISTINCT PE.Dosis, ';' ORDER BY PE.Dosis) AS DosisFrecuentes,
573     M.PrecioPublico,
574     M.Stock                               AS StockActual
575 FROM MEDICAMENTO AS M
576 INNER JOIN PEDIR AS PE
577     ON M.IDMedicamento = PE.IDMedicamento
578 GROUP BY
579     M.IDMedicamento,
580     M.PrecioPublico,
581     M.Stock
582 ORDER BY VecesRecetado DESC
```

Data Output

Messages

Notifications

≡

📄

▼

📄

🗑️

📤

📥

📊

SQL

	idmedicamento [PK] integer	vecesrecetado bigint	recetasdistintas bigint	dosisfrecuentes text	preciopublico numeric (10,2)	stockactual integer	
1		2	1	1	2 capsulas	770.09	123
2		3	1	1	1 tableta	430.12	132
3		4	1	1	5 ml	741.62	158
4		5	1	1	2 capsulas	101.88	184
5		6	1	1	1 tableta	736.45	208
6		7	1	1	5 ml	252.94	224
7		8	1	1	2 capsulas	102.39	240
8		9	1	1	1 tableta	205.73	259
9		10	1	1	5 ml	175.19	275
10		11	1	1	2 capsulas	179.05	298
11		12	1	1	1 tableta	517.58	315
12		13	1	1	5 ml	453.02	332
13		14	1	1	2 capsulas	571.41	349

10.10. Consulta xxiii — Recetas relacionadas con alergias

- Detectar medicamentos recetados pese a alergias registradas permite identificar posibles riesgos clínicos.
- Un número bajo de incidencias reflejaría buenos controles médicos.
- Casos repetidos podrían señalar errores en validaciones del sistema.

Query

Query History

585

-- Consulta xxiii

586

-- Pacientes con alergias registradas en alguna receta médica,

587

-- mostrando el diagnóstico asociado y los medicamentos que se

588

-- les recetaron pese a la alergia. Útil para auditoría clínica.

590

591

SELECT

592

C.IDCliente,

593

CONCAT(C.Nombre, ' ', C.ApellidoPaterno, ' ', C.ApellidoMaterno) AS NombrePaciente,

594

R.NumeroReceta,

595

R.Alergias,

596

R.Diagnostico,

597

STRING_AGG(DISTINCT PE.IDMedicamento::text, ' ' ORDER BY PE.IDMedicamento::text) AS MedicamentosRecetados,

598

CON.Fecha AS FechaConsulta

599

FROM CLIENTE AS C

600

INNER JOIN CONSULTA AS CON

601

ON C.IDCliente = CON.IDCliente

602

INNER JOIN GENERAR_CONSULTA_RECETA AS GCR

603

ON CON.IDConsulta = GCR.IDConsulta

604

INNER JOIN RECETA_MEDICA AS R

605

ON GCR.NumeroReceta = R.NumeroReceta

Data Output

Messages

Notifications

</

10.11. Consulta xxiv — Stock e inventario por sucursal

- Las sucursales con mayor stock probablemente atienden una demanda más alta.
- Inventarios demasiado grandes podrían generar costos innecesarios de almacenamiento.
- Inventarios bajos podrían provocar desabasto de medicamentos importantes.

Query

Query History

625

-- Consulta xxiv

626

-- Stock estimado de medicamentos por sucursal.

627

-- Se calcula como (total suministrado a la sucursal) - (total vendido en ella),

628

-- considerando todos los lotes de PROVEER_MEDICAMENTO y las ventas de COMPRAR.

629

630

WITH SuministrosPorSucursal AS (

631

SELECT

632

IDSucursal,

633

IDMedicamento,

634

SUM(Cantidad) AS TotalSuministrado

635

FROM PROVEER_MEDICAMENTO

636

GROUP BY

637

IDSucursal,

638

IDMedicamento

639

),

640

VentasPorSucursal AS (

641

SELECT

642

T.IDSucursal,

643

CO.IDMedicamento,

644

SUM(CO.Cantidad) AS TotalVendido

Data Output

Messages

Notifications

SQL

	idsucursal integer	nombre sucursal character varying (120)	id medicamento integer	totalsuministrado bigint	totalvendido bigint	stockestimadosucursal bigint
1	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	2001	37	0	37
2	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	2002	39	0	39
3	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	2003	41	0	41
4	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	2004	43	0	43
5	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	2005	45	0	45
6	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	2006	47	0	47
7	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	2007	49	0	49
8	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	2008	51	0	51
9	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	2009	53	0	53
10	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	2010	55	0	55
11	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	2011	57	0	57
12	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	2012	59	0	59
13	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	2013	61	0	61

10.12. Consulta xxv — Medicamentos próximos a caducar

- Una gran cantidad de medicamentos próximos a vencer representa pérdidas potenciales.
- Podría indicar mala rotación de inventario en ciertas sucursales.
- Permite priorizar promociones o redistribución de productos antes de su vencimiento.

Query

Query History

669

-- Consulta xxv

670

-- Medicamentos próximos a caducar (en los siguientes 90 días)

671

-- por sucursal, lote y proveedor, con la cantidad en inventario

672

-- y los días que faltan para el vencimiento.

673

674

SELECT

675

PM.IDSucursal,

676

S.Nombre AS NombreSucursal,

677

PM.IDMedicamento,

678

PM.IDProveedor,

679

PR.RazonSocial AS Proveedor,

680

PM.Cantidad,

681

PM.FechaDeRecibo,

682

PM.FechaDeCaducidad,

683

(PM.FechaDeCaducidad - CURRENT_DATE) AS DiasParaCaducar

684

FROM PROVEER_MEDICAMENTO AS PM

685

INNER JOIN SUCURSAL AS S ON PM.IDSucursal = S.IDSucursal

686

INNER JOIN PROVEEDOR AS PR ON PM.IDProveedor = PR.IDProveedor

687

WHERE PM.FechaDeCaducidad BETWEEN CURRENT_DATE AND CURRENT_DATE + INTERVAL '90 days'

688

Data Output

Messages

Notifications

+

↓

SQL

Showing rows: 1 to 50

Id sucursal integer	nombre sucursal character varying (120)	Id medicamento integer	Id proveedor integer	proveedor character varying (150)	cantidad integer	fecha de recibo date	fecha de caducidad date	días para caducar integer
1	Sucursal Los SuperDatos 0...	2061	13	Kwideo	17	2026-05-29	2026-06-09	11
2	Sucursal Los SuperDatos 0...	2051	3	Rhyzio	18	2026-05-29	2026-06-10	12
3	Sucursal Los SuperDatos 0...	2062	14	Twitterwire	21	2026-05-29	2026-06-12	14
4	Sucursal Los SuperDatos 0...	2063	15	Cogidoo	13	2026-05-29	2026-06-14	16
5	Sucursal Los SuperDatos 0...	2052	4	DigiTube	14	2026-05-29	2026-06-16	18
6	Sucursal Los SuperDatos 0...	2064	16	Podcat	26	2026-05-29	2026-06-17	19
7	Sucursal Los SuperDatos 0...	2065	17	Bluejam	18	2026-05-29	2026-06-19	21
8	Sucursal Los SuperDatos 0...	2066	18	Meetz	15	2026-05-29	2026-06-21	23
9	Sucursal Los SuperDatos 0...	2053	5	Chatterpoint	22	2026-05-29	2026-06-23	25
10	Sucursal Los SuperDatos 0...	2067	19	Topicware	20	2026-05-29	2026-06-24	26
11	Sucursal Los SuperDatos 0...	2068	20	Skaliit	16	2026-05-29	2026-06-26	28
12	Sucursal Los SuperDatos 0...	2069	21	Niounge	11	2026-05-29	2026-06-28	30
13	Sucursal Los SuperDatos 0...	2054	6	Muxo	16	2026-05-29	2026-06-29	31

10.13. Consulta xxvi — Proveedores de medicamentos e insumos

- Tener varios proveedores para un mismo producto reduce riesgos de desabasto.
- Productos con pocos proveedores generan mayor dependencia comercial.
- Ayuda a evaluar estabilidad de la cadena de suministro.

Query

Query History

```
694
695 -- Consulta xxvi
696 -- Medicamentos que son suministrados por más de un proveedor
697 -- (proveedores que compiten por el mismo producto), incluyendo
698 -- la cantidad total suministrada por cada proveedor y el
699 -- precio unitario promedio del medicamento.
700
701 WITH MedicamentosConMultiplesProveedores AS (
702     SELECT
703         IDMedicamento,
704         COUNT(DISTINCT IDProveedor) AS NumProveedores
705     FROM PROVEER_MEDICAMENTO
706     GROUP BY IDMedicamento
707     HAVING COUNT(DISTINCT IDProveedor) >= 2
708 )
709 SELECT
710     PM.IDMedicamento,
711     MCP.NumProveedores,
712     PR.IDProveedor,
713     PR.RazonSocial,
714     SUM(PM.Cantidad) AS CantidadTotalSuministrada,
```

Data Output

Messages

Notifications

10.14. Consulta xxvii — Ventas presenciales vs ventas en línea

- Un aumento de ventas en línea refleja adaptación digital de la empresa.
- Las sucursales con más ventas presenciales podrían depender de atención tradicional.
- Comparar ambos canales permite medir la efectividad de la plataforma digital.

10.15. Consulta xxviii — Comparación entre ingresos médicos y ventas de medicamentos

- Query** Query History

```
-- Consulta xxviii
-- Comparación de ingresos por venta de medicamentos vs ingresos
-- por consultas médicas, agrupado por sucursal. Muestra el
-- porcentaje del ingreso total que proviene de ventas para
-- identificar el modelo de negocio dominante de cada sucursal.
```

```
WITH IngresosVentas AS (
    SELECT
        T.IDSucursal,
        SUM(T.PrecioNeto) AS IngresosPorVentas,
        COUNT(DISTINCT T.IDTicket) AS NumeroTickets
    FROM TICKET AS T
    GROUP BY T.IDSucursal
),
IngresosConsultas AS (
    SELECT
        CL.IDSucursal,
        SUM(CON.CostoConsulta) AS IngresosPorConsultas,
        COUNT(CON.IDConsulta) AS NumeroConsultas
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1000

	IdSucursal [PK] integer	nombre sucursal character varying (120)	Ingresosporventas numeric	numerotickets bigint	Ingresosporconsultas numeric	numeroconsultas bigint	Ingresostotales numeric	porcentajeingresosventas numeric
1	4	Sucursal Los SuperDatos 0...	7060.43	20	11192.00	15	18252.43	39.68
2	3	Sucursal Los SuperDatos 0...	6753.15	19	9704.00	15	16457.15	41.03
3	2	Sucursal Los SuperDatos 0...	6416.09	20	8216.00	15	14632.09	43.85
4	1	Sucursal Los SuperDatos 0...	6447.06	20	6728.00	15	13175.06	48.93
5	6	Sucursal Los SuperDatos 0...	7906.55	8	1388.00	3	9294.55	85.07
6	5	Sucursal Los SuperDatos 0...	5488.11	9	3130.50	5	8618.11	63.68
7	8	Sucursal Los SuperDatos 0...	6977.20	8	1484.00	3	8461.20	82.46
8	20	Sucursal Los SuperDatos 0...	6673.82	2	1410.00	2	8083.82	82.56
9	9	Sucursal Los SuperDatos 0...	5974.50	8	1532.00	3	7506.50	79.59
10	105	Sucursal Los SuperDatos 1...	6207.30	2	1040.00	2	7247.30	85.65
11	10	Sucursal Los SuperDatos 0...	5638.24	7	1580.00	3	7218.24	78.11
12	125	Sucursal Los SuperDatos 1...	5246.51	2	1800.00	2	7046.51	74.46
13	140	Sucursal Los SuperDatos 1...	5476.82	2	1470.00	2	6946.82	

11. Conclusión

Con este proyecto se logró diseñar e implementar una base de datos para el caso de uso de *Una farmacia de otro mundo*, tomando en cuenta diferentes áreas de una cadena de farmacias, como sucursales, clientes, personal, proveedores, medicamentos, insumos, consultas médicas, recetas y tickets. A lo largo del desarrollo se buscó que la información estuviera organizada de forma clara y que las relaciones entre las tablas representaran de manera adecuada las reglas principales del negocio.

Durante el proyecto se aplicaron varios temas vistos en el curso. Primero se trabajó el análisis de requerimientos para identificar las entidades, atributos y relaciones más importantes del caso. Después se construyó el modelo Entidad–Relación y se tradujo al modelo relacional, cuidando el uso de llaves primarias, llaves foráneas y tablas intermedias cuando era necesario. También se implementó el modelo físico en PostgreSQL mediante instrucciones DDL, agregando restricciones para mantener la *integridad* de los datos.

Además, se pobló la base de datos con información suficiente para poder probar su funcionamiento y se realizaron consultas SQL que permiten obtener información útil sobre la administración de esta farmacia. Estas consultas ayudan a revisar aspectos como clientes registrados, medicamentos disponibles, proveedores, ventas, consultas médicas y actividad por sucursal. Así la base de datos no solo guarda información, sino que también permite analizarla y obtener reportes relevantes.

También se utilizaron procedimientos, funciones y disparadores para automatizar algunas tareas y reforzar reglas dentro de la base de datos. Sin embargo, estos elementos fueron solo una parte del proyecto, ya que el objetivo principal fue integrar todo el proceso de diseño, construcción, poblamiento y consulta de una base de datos funcional.

En general, el proyecto permitió reforzar la importancia de diseñar correctamente una base de datos antes de implementarla. Este trabajo ayudó a entender mejor cómo pasar de un problema descrito en lenguaje natural a una estructura organizada en tablas, relaciones y restricciones.

Como mejora futura, la base de datos podría conectarse con una aplicación web o móvil para que el personal de la farmacia pudiera usarla de forma más sencilla. También se podrían agregar más reglas de negocio, reportes administrativos y controles de seguridad. Aun así, la base desarrollada cumple con el objetivo principal del proyecto: representar de manera ordenada y funcional la información necesaria para administrar esta farmacia.